

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo científico-técnico alcanzado por la humanidad en materia de comunicación ha avanzado considerablemente y tiene repercusión en el campo de la logopedia, tanto en el ámbito de la salud como en el educativo. Sin embargo, existen situaciones no resueltas en cuanto a la calidad del tratamiento logopédico las cuales están relacionadas con la dimensión preventiva que debe asumirse desde los fundamentos de la didáctica general como núcleo de la pedagogía y de las didácticas particulares, con énfasis en la didáctica de la lengua por el valor que tiene para el desarrollo de la comunicación y la formación de la personalidad.

La prevención educativa tiene su concreción en la integración didáctica de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, las dimensiones del discurso, los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de enseñanza de la lengua, los procesos del habla y la escucha y el aspecto sonoro del lenguaje.

Estas ideas se han discutido en los informes de validación de la carrera de Logopedia (2012-13), en la superación posgraduada, la preparación metodológica con los maestros logopedas en ejercicio y egresados de la carrera, con la intención de mejorar la calidad en la formación desde una perspectiva didáctica.

Las sociedades humanas se organizan entre sí gracias a la comunicación. El individuo deviene en personalidad a partir de las condiciones humanas de vida y educación, en la actividad y la comunicación con el mundo de los objetos y las relaciones que establece con los que le rodean, mediante el proceso de socialización, en el que adquiere la experiencia histórico-cultural acumulada.

El tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral en el contexto escolar debe estar dirigido al desarrollo de los procesos del habla y la escucha, lo que facilita la interacción social de los escolares.

En la dislalia funcional se dificulta la discriminación de los sonidos de la lengua, el reconocimiento de las palabras y su significado en el contexto de la oración y los textos en general. También, las insuficiencias en la movilidad de los órganos articulatorios hacen que se afecte la comprensión y producción de significados.

Estudios internacionales y nacionales corroboran la incidencia de la dislalia o trastorno de la pronunciación en un porcentaje elevado de los escolares del primer ciclo de la Educación Primaria. Así lo evidencian investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación (1978, 1979), que muestran como 212 900 niños (13,06%) presentaban trastornos del lenguaje, de ellos el 73% se correspondía con trastornos aislados en la pronunciación.

Los datos de la exploración logopédica realizada en la provincia La Habana, durante el curso escolar 2011-2012, precisan que de un total de 633 niños con trastornos en la comunicación y el lenguaje, 150 (24%) presentan dislalia funcional.

Los referidos estudios revelan la pertinencia de esta investigación y demuestran que los trastornos de la pronunciación (dislalia) son los más frecuentes en la población infantil.

Las investigaciones realizadas sobre el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral en el escolar primario con dislalia funcional a nivel internacional, reflejadas en los trabajos de P. Pascual (1981); J. R. Gallardo, J. L. Gallego (1993); J.

M. Gorospe, M. Garrido, J. Vera y J. Málaga (1996); A. Sos y M. L. Sos (1997); F. S. Mata (1999), se dirigen al estudio de la naturaleza del trastorno, su diagnóstico y carácter primario, además aportan criterios para el desarrollo de las praxias fonoarticulatorias y la discriminación auditiva.

A nivel nacional se valora la contribución de destacados autores como: M. Martín, I. Méndez; R. Prado (1980); E. Figueredo, N. López, S. Borges (1984); E. Pérez y O. Calzadilla (1997); C. L. Cobas (2007); I. Fernández y G. Vázquez (2008); J. R. Montalvo (2010); M. D. Cruz (2011, 2013); G. Fernández y X. Rodríguez (2012); B. Martínez (2012).

En estos estudios se ofrecen modelos de tratamiento logopédico, etapas para su dirección, juegos y ejercicios para la corrección de la dislalia, orientaciones al maestro de aula, se enfatiza en el uso de las tecnologías para el tratamiento a este trastorno, en la importancia del desarrollo de la comunicación oral; así como en la estructura y contenido del tratamiento logopédico y en la dimensión preventiva desde un enfoque ontogenético, de diagnóstico y estimulador del desarrollo, sin embargo, hay aspectos no esbozados, desde el punto de vista didáctico, en los que se debe profundizar para elevar su calidad.

La experiencia de la autora en la especialidad de Logopedia, la revisión de las fuentes bibliográficas, la observación a tratamientos logopédicos en la Educación Primaria, la encuesta realizada a maestros logopedas y las entrevistas aplicadas a los maestros de aula y familias, así como el hecho de que la dislalia funcional se mantenga como el trastorno más frecuente en la población infantil, permitieron identificar la siguiente situación problemática, que ha constituido, hasta el momento, un aspecto no resuelto

en el que se manifiestan carencias teórico-metodológicas en el tratamiento logopédico referidas a:

- Insuficiente empleo de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje y los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y socio-cultural en la enseñanza de la lengua.
- Dificultades en la integración de las dimensiones del discurso, se pondera el trabajo con la pronunciación.
- Dificultades en la selección del material verbal en coherencia con el objetivo.
- Insuficiente tiempo dedicado al desarrollo de las bases funcionales del habla y la escucha.
- Escaso uso de recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación oral.
- Insuficiente orientación a los agentes de socialización para la continuidad del tratamiento logopédico.

El análisis de estos aspectos genera la contradicción que se manifiesta entre la necesidad de mejorar el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional y las insuficiencias en la concepción metodológica de este tratamiento para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario.

Los aspectos planteados conducen a formular el siguiente **problema científico**:

¿Cómo mejorar el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional?

El **objeto de estudio** de la investigación es el tratamiento logopédico del escolar primario. Se precisa como **campo de acción**: el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional. Para dar solución al problema científico, se plantea como **objetivo**: proponer una metodología que contribuya al mejoramiento del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral, del escolar primario de los grados iniciales con dislalia funcional. Guían la investigación las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional?
2. ¿Cuál es el estado actual del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario de los grados iniciales con dislalia funcional?
3. ¿Qué características debe tener una metodología que contribuya al mejoramiento del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación **oral**, del escolar primario de los grados iniciales con dislalia funcional?
4. ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de la metodología elaborada?

En correspondencia con las preguntas científicas se plantean las siguientes **tareas investigativas**:

1. Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.
2. Caracterización del estado actual del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario de los grados iniciales con dislalia funcional.
3. Elaboración de una metodología que contribuya al mejoramiento del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario de los grados iniciales con dislalia funcional.
4. Valoración de los resultados que se obtienen con la aplicación de la metodología elaborada.

La metodología de la investigación utilizada se sustenta en la concepción dialéctico-materialista de la filosofía marxista leninista, que permite estudiar el objeto en su desarrollo y fundamentar la metodología que se propone para mejorar la calidad del tratamiento logopédico. Se aplican métodos de los niveles teórico, empírico y los matemático-estadísticos.

#### **Métodos teóricos:**

El histórico-lógico, posibilitó el estudio, análisis y determinación de los antecedentes del tratamiento logopédico en presencia de dislalia funcional, así como los enfoques teóricos y metodológicos empleados en la evolución de las ideas pedagógicas.

El analítico-sintético: permitió el estudio de las fuentes bibliográficas para la conformación del marco teórico, el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, la valoración de la metodología propuesta y la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

El sistémico estructural: facilitó la integración de los componentes básicos y el sistema de relaciones en la conformación de la metodología. La modelación: permitió realizar las abstracciones necesarias para analizar los nexos y las relaciones que se producen durante el tratamiento logopédico a partir de una concepción didáctico-metodológica basada en la dimensión preventiva.

### **Métodos y técnicas empíricas:**

El análisis documental: incluyó el estudio del expediente acumulativo del escolar para la caracterización psicopedagógica, el logopédico, con el objetivo de analizar el proceso de diagnóstico e intervención logopédica, la libreta de visitas a clases y orientaciones al maestro y la de labor social, para confrontar información recogida y las orientaciones que brinda el maestro logopeda a los agentes de socialización (maestros de aula y familia).

La encuesta: se aplicó a maestros logopedas con el objetivo de constatar el dominio que tiene este profesional del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional. La técnica de exploración logopédica: se realizó para diagnosticar la comunicación oral de los escolares de primero y segundo grado investigados.

La observación a tratamientos logopédicos: con el objetivo de identificar los principales problemas manifiestos por el maestro logopeda en la dirección del tratamiento logopédico. La entrevista a maestros de aula y la familia: para valorar los conocimientos que poseen estos, en relación con las particularidades de la comunicación oral de los escolares y las orientaciones que reciben del maestro logopeda como agentes de socialización que apoyan esta actividad pedagógica desde el contexto escolar y familiar.

Se empleó la triangulación de fuentes para revelar la coincidencia o dispersión de la información a partir de los métodos empíricos aplicados y el método experimental, en su variante de pre-experimento, para constatar la validez de la metodología propuesta.

**Métodos estadísticos y/o matemáticos:** se empleó el procesamiento matemático, el análisis porcentual, para determinar regularidades en los datos obtenidos y la valoración de los resultados. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica Kolmogorov Smirnov en una escala ordinal con tres rangos y la utilización de la mediana como medida de tendencia central para el estudio de su confiabilidad.

La selección del **grupo de estudio** es intencional, de acuerdo con los fines de la investigación. El grupo A: 25 maestros logopedas que atienden a escolares de primer ciclo con dislalia funcional; el grupo B: 25 escolares primarios que presentan dislalia funcional; el grupo C: 15 maestros de aula con más de 5 años de trabajo en la educación primaria y el grupo D: 15 familias que sus hijos presentan dislalia funcional.



La **novedad científica** se revela en la concepción didáctico-metodológica para mejorar el tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, con énfasis en los recursos metodológicos para el desarrollo del habla y la escucha, que constituyen mediadores para enriquecer el trabajo con la lengua materna desde los primeros grados.

La **contribución a la teoría** se expresa en la metodología, a partir del sistema de relaciones que se establece de manera jerárquica entre los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha, con el empleo de recursos metodológicos para mejorar el tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.

La **significación práctica** se ofrece un instrumento metodológico al maestro logopeda para mejorar el tratamiento logopédico, que los orienta en el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional. También, incluye talleres metodológicos y folletos para la preparación a los maestros logopedas, así como folletos de orientación a maestros de aula y a la familia, quienes favorecen este proceso desde las primeras edades.

La tesis se estructura en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 16 anexos. En el primer capítulo se presentan los fundamentos teórico-metodológicos para mejorar el tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional. Se analiza cómo han evolucionado las ideas en el ámbito médico y educativo, así como

los retos desde el punto de vista didáctico para mejorar esta actividad, con énfasis en la dimensión preventiva.

En el segundo capítulo se constata el estado actual del problema objeto de estudio, se precisan sus regularidades a partir de la caracterización de las dimensiones e indicadores. Se destacan las fortalezas y debilidades para la elaboración de la metodología que se propone.

En el resultado científico se destaca el proceder metodológico a seguir mediante etapas y pasos, además se distinguen los recursos metodológicos empleados para integrar, desde una visión preventiva, el sistema de relaciones que deben considerarse desde el punto de vista didáctico-metodológico para mejorar el tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, como trastorno más frecuente en la población infantil.

El tema investigado ha sido publicado en la revista científica del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), en el 2011 y 2013, se ha presentado en eventos de Pedagogía Provincial (2012), en jornadas científicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, en el Primer Taller de Didáctica de la Educación Especial (2012), en el Seminario Nacional para Educadores (2013), en la Maestría de Atención a la Diversidad de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (2014) y en la Comisión Nacional de Carrera (2014).

## **CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL TRATAMIENTO LOGOPÉDICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL ESCOLAR PRIMARIO CON DISLALIA FUNCIONAL**

En el capítulo se tratan los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional y en particular, los que cursan los grados iniciales de la Educación Primaria. Se enfatiza en esta población por ser la que con mayor frecuencia presenta este trastorno, el que incide en el desarrollo de la lengua materna y el aprendizaje en general.

### **1.1. Modelo de educación primaria como contexto de investigación.**

La escuela cubana tiene la misión de la formación integral de las futuras generaciones, preparándolas para vivir en su tiempo, una época de desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica, cuyo impacto en la práctica social es tan grande y en ocasiones tan rápido, que se precisa de una concepción del desarrollo infantil que asegure una mayor vigencia de los conocimientos y sus posibilidades de aplicación a nuevas condiciones, para formar un ser creativo, con una mente flexible, abierta a la experiencia, de lo que se deduce que el modelo actuante debe responder a esas exigencias.

En esta investigación, constituye un referente esencial, los resultados de las investigaciones realizadas en el contexto de la Educación Primaria por G. Fernández (2002), elabora una estrategia psicopedagógica para el tratamiento logopédico a escolares con trastornos del ritmo y la fluidez del lenguaje (tartamudez), E. Pérez (2003), propone un programa de ayuda logopédica para corregir la tartamudez en niños,

adolescentes y jóvenes, A. Díaz (2007), elabora una alternativa curricular para el desarrollo de la expresión oral en los escolares de la escuela primaria, L. Nikolaevna (2008), desarrolla una metodología para la estimulación de la comunicación verbal de escolares con necesidades educativas especiales en el desarrollo general del lenguaje, J. C. Aguado (2009), propone una metodología basada en el análisis de la estructura fonológica para la comprensión y construcción de textos escritos en cuarto grado.

El Modelo de Escuela Primaria es un modelo pedagógico. R. A. Sierra define el modelo pedagógico como: *"Construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta"* (2008:84). Se reconocen en esta definición el valor explicativo, de pronóstico y transformador que debe tener el modelo para la dirección del proceso pedagógico.

Se entiende además que el modelo pedagógico debe constituir un instrumento teórico-metodológico que oriente a los educadores en el diagnóstico y la estimulación del desarrollo de los escolares.

Desde su diseño debe precisar los logros alcanzados por los escolares en la comunicación y el lenguaje *"...los modelos son dinámicos, no estáticos, reflejan las características de un momento determinado en la historia del problema, las tendencias del desarrollo científico, las necesidades sociales..."* (Sierra, R. A., 2008:23).

Este modelo debe responder a nuevos imperativos relacionados con el tratamiento logopédico por su importancia para el desarrollo de la lengua materna, con mayor intencionalidad en los escolares que presentan trastornos de la comunicación.

El Modelo de Escuela Primaria se fundamenta en el enfoque histórico cultural, centrado en el desarrollo integral de la personalidad, sus leyes y principios, de los cuales se deriva el fin de la educación primaria: *“contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista”* (Rico, P. 2008:19).

Para el logro de este propósito, en el modelo se concretan los objetivos generales del nivel primario y de los grados que comprende. En él se propone el análisis de los métodos a utilizar e indicadores de evaluación y diagnóstico de las acciones a ejecutar en la escuela para elevar la calidad del proceso educativo y un análisis del desarrollo del escolar primario por etapas; sin embargo, la caracterización lingüística requiere de una mayor profundización para la prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Se plantean modos de dirección del proceso docente educativo, la organización escolar, el trabajo metodológico y alternativas para la orientación familiar.

En el referido modelo se ha de enfatizar en los aspectos metodológicos relacionados con la didáctica del tratamiento logopédico y la gestión educativa del maestro logopeda con el maestro de aula y la familia a favor del desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los diferentes contextos de actuación.

No obstante, la diversidad de cambios en el desarrollo que se producen en los escolares de este nivel, hacen que la escuela primaria determine particularidades en cuanto a su estructura y organización que puedan dar respuesta a las necesidades e intereses de

estos, desde el más pequeño de primer grado hasta el de sexto grado. Esta variedad de edades requiere, para una mejor atención pedagógica, la consideración de logros de acuerdo con los momentos parciales del desarrollo que se correspondan con determinadas particularidades psicológicas y lingüísticas de los escolares, cuyo conocimiento permite al maestro logopeda y de aula dirigir las acciones educativas con más calidad y a los escolares, transitar con éxito por los grados y ciclos en función de su desarrollo.

Desde el punto de vista de lo que se quiere lograr, se aspira a la formación de un escolar reflexivo, crítico e independiente, que asuma un rol cada vez más protagónico en su actuación. Para ello el fin de la escuela primaria se concreta en el desarrollo de los objetivos y específicamente, los escolares al concluir el primer ciclo deben expresar las ideas de forma oral y escrita, con unidad, claridad, calidad y coherencia, redactar textos de diversas estructuras, con buena caligrafía y aplicar de forma adecuada las diversas reglas ortográficas y gramaticales estudiadas, leer textos con corrección, fluidez, expresividad y mostrar comprensión de lo leído.

El desarrollo del escolar primario transita por tres momentos: de 6 a 7 años (primero y segundo grados), de 8 a 10 años (tercero y cuarto grados) y de 11 a 12 años (quinto y sexto grados). Según investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas: P. Rico, M. Bonet, S. Castillo, M. García, V. Martín-Viaña, C. Rizo, E. M. Santos: *“El nivel primario constituye una de las etapas fundamentales en cuanto a adquisiciones y desarrollo de potencialidades del niño...”*. (Rico, P., et al, 2008:35). Y estas adquisiciones *“...son premisas importantes a consolidar en etapas posteriores”* (Rico, P., et al, 2008:35).

En esta investigación se toma como referente el primer ciclo de la Educación Primaria, fundamentalmente, los grados iniciales, por su carácter propedéutico y por el valor preventivo del tratamiento logopédico, el que tiene su antesala desde la primera infancia, donde se deben considerar los logros en esas edades y específicamente en el grado preescolar se adquieren y consolidan prerrequisitos básicos, que han de alcanzar los escolares, relacionados con el desarrollo perceptivo, sensomotriz, del lenguaje y afectivo, que los prepara para la vida.

El ingreso a la escuela provoca un vuelco en la vida del escolar. Aparece la actividad de estudio como núcleo de este régimen. El momento de desarrollo de primero a segundo grado, se corresponde con las adquisiciones más importantes referidas a los procesos de la lectura y escritura, cuyas bases se inician en el grado preescolar, así como el conocimiento de las operaciones elementales de cálculo y de nociones primarias sobre la naturaleza y la sociedad.

Un logro importante del desarrollo lo constituye el carácter voluntario y consciente que adquieren los procesos psíquicos. En los primeros grados, la percepción tiene un carácter más analítico, el escolar destaca muchos detalles sin separar lo esencial de lo secundario, mientras se torna más sintética en grados posteriores. Si el maestro logopeda trabaja la comparación, la generalización en el tratamiento logopédico, permite a los escolares el establecimiento de relaciones y la interpretación de lo percibido.

La memoria, aumenta la rapidez de fijación, el volumen de retención, adquiere carácter voluntario y se hace cada vez más lógica. El escolar debe establecer relaciones entre los conceptos que asimila, con sus propias palabras y en un lenguaje comprensible para

los otros, expresándose así la relación entre memoria, pensamiento y lenguaje. Ello significa que el maestro logopeda debe estructurar el material verbal de forma tal que promueva su retención lógica por parte del escolar.

La atención, adquiere un carácter voluntario. Resulta fundamental la forma en que el maestro logopeda estructura el proceso de asimilación de los contenidos para lograr que estos despierten el interés del escolar, desarrollen una actitud consciente, de confianza, según los conocimientos adquiridos.

En las edades de 6 a 7 años, la formación de conceptos con lo que opera el pensamiento, debe apoyarse en lo directamente perceptible, en el objeto concreto determinado o su materialización mediante modelos, el análisis, la síntesis, la abstracción y la generalización son operaciones del pensamiento que se desarrollan en estos grados y que el maestro debe operacionalizar en acciones tales como: la observación, la descripción, la comparación, la clasificación de objetos, entre otras habilidades, que favorezcan las formaciones primarias sobre objetos y fenómenos que adquieren significados y sentido para estos escolares.

En la esfera afectivo-motivacional, los escolares orientan su comportamiento no sólo por objetivos que les plantean los adultos, sino por otros que se proponen conscientemente, lo que les permite lograr un control más activo de su conducta.

De igual modo se expresa esta voluntariedad en los procesos cognitivos, lo que muestra que la unidad de lo cognitivo y lo afectivo alcanza un mayor nivel y se convierte en la base de la consolidación de las formaciones motivacionales complejas, ideales,



autovaloración, entre otros, que caracterizan a la personalidad en etapas posteriores del desarrollo.

La actividad cognoscitiva de los escolares, necesita estar bien orientada en la tarea, conocer qué se espera de ellos, poseer las condiciones y elementos para realizarla. Solo así podrán desde estos primeros grados, participar en el control de los resultados de la actividad y de su propia actuación, detectar sus errores y tratar de corregirlos. El hecho de que la actividad rectora sea el estudio, no significa limitar la práctica del juego, porque este constituye una actividad física y psíquica con alto valor educativo para la formación de la personalidad.

Desde los primeros grados se trabaja la cualidad de reflexión para lograr el desarrollo gradual del pensamiento, así como los intereses y necesidades de la edad mediante el juego para que los motive y despierte el interés por aprender.

Se produce un autocontrol gradual de las excitaciones físicas al disminuir la excitabilidad de los escolares. Las vivencias emocionales están muy vinculadas al éxito escolar, las que gradualmente pasan a depender de las relaciones con sus compañeros y del lugar que ocupan en el grupo.

En esta etapa es importante la acción educativa dirigida al desarrollo de los sentimientos sociales y morales como la responsabilidad, a partir de los vínculos de la escuela, la familia y la comunidad con una acción educativa coherente. Se desarrollan cualidades de la personalidad como la ayuda mutua, la modestia, sentimientos de afectos hacia los otros que evidencian avances en su desarrollo social.

En cuanto al sistema de comunicación, en los primeros grados el maestro constituye una autoridad sagrada y sus criterios influyen de forma decisiva en el desarrollo de la autovaloración del escolar y su aceptación o rechazo. Los escolares no solo utilizan el lenguaje para denominar objetos, personas allegadas y expresar sus ideas, necesidades y emociones, sino que se convierte en un medio fundamental de adquisición de conocimientos. El lenguaje situacional, aunque no desaparece en sus inicios, comienza a ser desplazado por el lenguaje coherente, necesario para la comprensión de los diferentes contenidos del grado y desarrollar la capacidad de expresar lo aprendido, de forma comprensible para los demás.

El maestro logopeda debe propiciar que los escolares se expresen de forma espontánea, libremente, sin restricciones, que respondan y elaboren preguntas, que dialoguen (qué decir y cómo decirlo); que se escuchen y expongan sus ideas para favorecer la comprensión y construcción de textos orales diversos.

Por primera vez, el escolar comienza a utilizar el lenguaje escrito, aspecto que contribuye a la coherencia del lenguaje hablado; al situarlo ante la necesidad de estructurar de forma gramaticalmente adecuada sus expresiones verbales, *“...en tanto el pensamiento opera mediante conceptos que se definen con palabras”* (Vigotski, L. S., 1982:24). De esta forma se evidencia la relación de las funciones básicas del lenguaje (cognitiva y comunicativa).

En este sentido, el tratamiento logopédico constituye una vía esencial para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares mediante diferentes situaciones comunicativas.

También se intercambian ideas, opiniones, se aprende a apreciar lo bello y aceptar críticas y sugerencias realizadas por sus compañeros y maestros.

El interés por la comunicación oral se debe estimular con temas sugerentes, incluso por los propios escolares, que emanen de sus experiencias, e inquietudes por saber, de sus posibilidades, necesidades, motivaciones y el nivel de desarrollo de su medio social. Estos elementos contribuyen a elevar su autoestima, la seguridad en sí mismo y la aceptación de sus propios errores.

Lo anterior indica el lugar esencial que desempeña la comunicación que se establece entre maestro-escolar, escolar-escolar y la que establece el escolar con otras personas que lo rodean. Al respecto L. S. Vigotski afirmó: *“...a las preguntas de dónde se toman, cómo se forman y por qué vía se desarrollan los procesos superiores del pensamiento infantil, debemos responder que estos surgen en el proceso del desarrollo social del niño, mediante el traslado hacia sí mismo de las formas de colaboración que el niño asimila en el proceso de interacción con el medio social circundante”* (1982:24).

Por tanto, resulta importante el modelo comunicativo de todos los agentes de socialización que interactúan con los escolares, el maestro logopeda, de aula y la familia. Se ha de enfatizar en la toma de conciencia acerca de la importancia del silencio, de la necesidad de escuchar para participar activamente en las diferentes interacciones verbales y mostrar respeto por las normas básicas de interacción verbal en cualquier situación comunicativa. De ahí el valor de la labor del maestro logopeda desde las primeras edades, con una visión preventiva para potenciar el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario.

## 1.2. Consideraciones generales sobre el tratamiento logopédico. Antecedentes.

Estudios realizados en el contexto internacional por A. Kussmaul (1879); H. Gutzman, y P. Liebmann (1924); E. Fröschels (1928) y en el contexto nacional por E. Figueredo, M. López, S. Borges (1984); G. Fernández (1986, 2008) y M. López (1986); I. Fernández y G. Vázquez (2008); G. Fernández, y X. Rodríguez (2012), entre otros, corroboran que desde épocas remotas se hacían intentos de tratamiento logopédico.

Estos intentos, carecían de un fundamento científico, se correspondían con los conocimientos de la época, quedan reflejados desde Hipócrates, Demóstenes, quienes se preocupaban por desarrollar la respiración, Aristóteles exigía, que en el discurso oratorio, se tuvieran en cuenta la fuerza, la armonía y la voz. Aspectos básicos para el desarrollo de la comunicación oral en el tratamiento logopédico.

Se consideran momentos importantes como antecedentes las escuelas fundacionales de Logopedia y Foniatría, la berlinesa, establecida por H. Gutzmann, en 1894, sus postulados eran básicamente organicistas, absolutizaba el aspecto biológico en el surgimiento, desarrollo y eliminación de los trastornos del lenguaje, y la vienesa, establecida por E. Fröschels, en 1911, quien le imprime un sello más psicológico y facilita una orientación decisiva hacia la terapéutica funcional. Ambas escuelas constituyen un referente teórico importante, para determinar el carácter orgánico y funcional de las dislalias y dirigir el tratamiento logopédico en este sentido.

La neurofisiología moderna, representada en la figura de A. R. Luria, en 1982; I. P. Pavlov, en 1984, citado por E. Figueredo (1984), revela la idea de la corteza cerebral como una unidad funcional, aspecto importante para comprender la relación entre las

diferentes zonas del cerebro encargadas de la comprensión y producción del lenguaje oral y su mecanismo de afectación ante determinado trastorno. El concepto de función y la teoría de la unidad de los sistemas funcionales permitieron comprender que el lenguaje constituye un sistema funcional complejo.

Aún cuando la Logopedia es una ciencia joven, su historia, resulta interesante, y muchos investigadores entre los que se destacan M. Martín, y otros (1980); G. Fernández y M. López (1986); E. Pérez y O. Calzadilla (1997); E. Pérez (2003); M. E. Morales (2004); el colectivo de autores de Ciencias Médicas, representado en la figura de L. Álvarez (2007); L. Nikolaevna (2008); C. L. Cobas (2010); G. Fernández y X. Rodríguez (2012); M. Pons (2012), han contribuido desde sus referentes teóricos, al desarrollo del tratamiento logopédico, particularmente en Cuba.

En la búsqueda de los antecedentes teóricos y metodológicos en los que se ha sustentado el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral, se distinguen enfoques, formas de organización, la estructura y contenido como puntos de partida para su análisis. En su evolución histórica se consideró la periodización realizada por G. Fernández y X. Rodríguez (2012), expresada en dos importantes etapas: (antes y después del triunfo revolucionario), las que se retoman como parte de los antecedentes:

Etapa 1. El tratamiento logopédico antes del triunfo revolucionario. (1921–1959)

Etapa 2. El tratamiento logopédico después del triunfo revolucionario. (1959 hasta la actualidad).

La primera etapa se caracteriza por un enfoque clínico del tratamiento logopédico, este se dirige a la búsqueda de las causas de los trastornos de la comunicación y se

desarrollaba fundamentalmente en instituciones de salud pública y en centros psicopedagógicos. Se profundiza en el proceso de diagnóstico desde esta perspectiva.

Castellanos Peláez, en 1921, citado por G. Fernández y X. Rodríguez (2012), investiga en el nivel comunicativo habla, el componente ritmo y fluidez verbal y dedica su estudio al tratamiento correctivo de la tartamudez en la enseñanza primaria, se refiere a la presencia de espasmos a nivel del aparato articulatorio, respiratorio y de fonación.

La apertura del “Instituto Psicopedagógico Crespo”, en 1939, se corresponde con los inicios del tratamiento logopédico en instituciones educativas y la creación del gabinete de Ortofonía adscrito al laboratorio Psicopedagógico, con el objetivo de investigar los trastornos de la articulación y el lenguaje para su tratamiento científico.

Un momento importante lo constituye la llegada a Cuba de D. Weis (1941-1946), quien comienza una ardua labor médica y asistencial. Además, desarrolló un modelo de tratamiento logopédico rehabilitativo, paraclínico, denominado por algunos especialistas como: modelo médico o médico-pedagógico, que posteriormente continúa R. Cabanas (1946).

La forma de organización del tratamiento logopédico era esencialmente directa e individual, por la relación médico-paciente que el tipo de atención demandaba. La frecuencia y duración dependían del origen del trastorno, el objetivo se reducía a erradicar o compensar los trastornos verbovocales, lo que resulta insuficiente para potenciar el desarrollo de la comunicación oral desde una visión preventiva de la educación, los métodos que se empleaban eran la intervención quirúrgica o la aplicación

medicamentosa, los medios se relacionaban con el instrumental clínico-quirúrgico o terapéutico.

La teoría acerca del surgimiento, el mecanismo y la atención a los trastornos de la comunicación oral se sustentó en las ideas del médico vienés E. Fröschels: “la masticación sonora” como base para el tratamiento a los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

La primera etapa se caracteriza por la búsqueda de las causas de los trastornos para su corrección y compensación, se centra en el defecto, lo que evidencia insuficiencias teórico metodológicas en el tratamiento logopédico.

En la segunda etapa, después del triunfo de la Revolución, se inicia un período de formación de maestros logopedas por el Ministerio de Educación, a partir de la creación de los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO) y de escuelas especiales en todo el país, (década de los años 60 al 70), que continuaron bajo el enfoque clínico.

En la década de los años 70, hay un perfeccionamiento del subsistema de Educación Especial. En 1977, por resolución ministerial 474 se inicia el tratamiento logopédico en la escuela primaria, que posteriormente en la década de los 80, se extiende a todo el país por la prolongación paulatina de la carrera de Logopedia a otros Institutos Superiores Pedagógicos.

A partir de esta década y hasta la actualidad la forma de organización es individual y/o colectiva de hasta cinco escolares en un tratamiento logopédico, en estrecha interacción escolar-logopeda. El tratamiento logopédico comienza a direccionarse con un enfoque psicopedagógico, se combinan los métodos clínico-terapéuticos con la utilización de la

clasificación psicopedagógica. Sobre esta última, la autora coincide con E. Figueredo al expresar entre sus principales limitaciones: “...excluír los trastornos de vocalización en la práctica pedagógica y esquematizar la ubicación de los trastornos en general” (Figueredo, E, et al., 1984:42).

La esquematización de la ubicación de los trastornos, genera dificultades en el diagnóstico para delimitar en qué grupo de la clasificación ubicar las características de la exploración logopédica, al no considerar los niveles de gravedad en que estos pueden aparecer (trastorno fonético aislado, solo se afecta la pronunciación; insuficiente desarrollo de los procesos fonético-fonemáticos, se afecta la pronunciación y la discriminación de los sonidos de la lengua; insuficiencia general en el desarrollo del lenguaje, dificultades en los componentes esenciales de la lengua: fónico, léxico, gramatical y pragmático), además, no se considera la voz, aspecto esencial para el habla.

Un importante aporte en la década de los años 80, lo constituye el libro *Los métodos para el tratamiento logopédico*, de M. Martín y otros (1980). En él se ofrecen orientaciones metodológicas, se precisan las características, defectos y correcciones de cada sonido, que mantiene su actualidad en la práctica logopédica, sin embargo no aborda algunos elementos didácticos esenciales en cuanto a la estructura y contenido de este, jerarquiza el trabajo con la pronunciación, en coherencia con el enfoque clínico.

Por otra parte, E. Pérez y O. Calzadilla (1997), contemplan en el tratamiento logopédico, una parte inicial o introductoria, actividades correctivas, conclusiones y dentro de ellas la evaluación y la tarea. Estas autoras introducen nuevos elementos, pero tampoco



profundizan en los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso, los procesos de habla y escucha como base de la comunicación oral.

Las primeras décadas del actual siglo XXI, se caracterizan por la reorganización y elevación de la calidad del tratamiento logopédico, en los ámbitos de la salud y el educativo, en coherencia con el vínculo entre estas instituciones y los enfoques en la formación del maestro en Educación Especial y Logopedia: el ontogenético, de diagnóstico y terapéutico. Este último se transforma en estimulador del desarrollo (Betancourt, J., 1995). Desde esta perspectiva se enfatiza en su carácter preventivo; no obstante se evidencian insuficiencias en los elementos didácticos que lo distinguen de una clase frontal como parte del currículo.

Al reconocer la prevención como una dimensión del proceso educativo, según R. Rodríguez *“...desde la que se ejercen influencias que potencien su calidad, a la vez que se atenúan, disminuyen o evitan aquellas que la afectan, con una posición consciente y activa de todos sus participantes” (2010:15.)*

Se asume esta posición por su valor para el tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral, a partir del respeto a la condición del desarrollo de la persona y a la orientación de los diferentes agentes de socialización, quienes desempeñan un rol fundamental como mediadores de su desarrollo.

En el tratamiento logopédico, la prevención como dimensión de la educación, considera los enfoques ontogenético, de diagnóstico y estimulador del desarrollo; con el propósito de satisfacer las demandas educativas de los escolares para favorecer la comunicación.

Al conocer cuáles son las adquisiciones de la edad escolar, qué cambios ocurren y en qué condiciones sociales de existencia, cómo estas últimas preparan al escolar para esta etapa, qué retos plantean las nuevas condiciones de entrada a la escuela, puede determinarse con mayor precisión el momento en que surgen los trastornos de la comunicación oral, las causas, así como sus manifestaciones, que de ser detectadas a tiempo y tratadas de forma oportuna, no llegarían a instaurarse como dificultades que entorpezcan la comunicación y el aprendizaje de los escolares.

En el desarrollo del tratamiento logopédico se destacan otros autores que han realizado contribuciones puntuales como: G. Fernández (2002), enfatizó en los métodos psicopedagógicos basados en las terapias artísticas y el de facilitación, que incluye la relajación psicofísica y activa verbal (respiración, trabajo verbal, lectura, narración y el monólogo) para la corrección de la tartamudez del escolar primario; C. L. Cobas (2007), ofrece orientaciones a los maestros para la atención a los trastornos vocales, del habla y del lenguaje, desde las potencialidades del currículo escolar, además, propone juegos y ejercicios para el desarrollo de la atención auditiva, del oído fonemático y la motricidad articulatoria.

Por otra parte, I. Fernández, y G. Vázquez (2008), se refieren a los recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico, los que tienen un valor importante como

recursos, apoyos y ayudas para satisfacer necesidades comunicativas, adquirir experiencias culturales para su desarrollo individual y social.

G. Fernández y M. C. García (2010), elaboran un folleto referido a la organización de la atención logopédica integral en las instituciones educativas, dirigido a los maestros logopedas, el cual constituye un documento de consulta para el tratamiento logopédico que se debe desarrollar en la escuela. En este folleto, se reflejan las etapas de la atención logopédica y las acciones a realizar en cada una de ellas.

Autores foráneos y cubanos han enriquecido la teoría y la práctica del tratamiento logopédico: P. Pascual (1981); J. R. Gallardo y J. L. Gallego (1993); A. Sos y M. L. Sos (1997); S. F. Mata (1999). En el contexto cubano, ha sido abordado por autores como: M. Martín y otros (1980); E. Figueredo y otros (1984); E. Pérez, O. Calzadilla (1997); G. Fernández (2002); M. E. Morales (2004); C. L. Cobas (2007); L. Nikolaevna (2008); M. D. Cruz (2011- 2013) X. Rodríguez (2010-2012), entre otros.

En relación con el tratamiento logopédico se emplean diferentes términos indistintamente como: clase o tratamiento logopédico, M. Martín y otros (1980); G. Fernández y X. Rodríguez (2002-2012), ayuda logopédica, E. Pérez (2003) y L. Nikolaevna (2008); acciones psicopedagógicas, M. E. Morales (2004). En la investigación se asume el término clase o tratamiento logopédico, por ser el que tiene mayor reconocimiento por la comunidad científica.

M. E. Morales, define el tratamiento logopédico como *“...sistema de acciones o tareas basadas en el diagnóstico logopédico que tiene un carácter psicopedagógico y están*

*dirigidas a la prevención, atención, evaluación e investigación científica de la comunicación humana y sus trastornos” (2004: 35).*

Resulta interesante la precisión que hace la autora de dos aspectos básicos, el diagnóstico logopédico para la prevención y atención a los trastornos de la comunicación y el lenguaje y la investigación permanente para perfeccionar su desempeño, sin embargo, el carácter psicopedagógico en la práctica educativa ha de ser mejorado porque desde el punto de vista metodológico la clasificación que se utiliza en la actualidad es la médica por su valor para la corrección y/o compensación de los trastornos en los niveles de la comunicación (habla, lenguaje, voz).

X. Rodríguez plantea que el tratamiento logopédico *“Constituye una actividad pedagógica especialmente dirigida al desarrollo de la comunicación y el lenguaje, con fines preventivos, en la que se emplean recursos metodológicos para la corrección y/o compensación del lenguaje oral y escrito, de forma individual, en pareja y/o grupal. En ella se satisfacen las demandas educativas de los escolares para el empleo de un habla inteligible y el desarrollo de un lenguaje coherente, fluido y expresivo” (2012:3).*

Esta autora reconoce el valor del desarrollo de la comunicación oral y el uso de los recursos metodológicos para la prevención, corrección y compensación de los trastornos del lenguaje, así como los niveles de la comunicación para su desarrollo lingüístico; también explicita las formas de organización.

G. Fernández y X. Rodríguez (2012), en la organización del tratamiento logopédico, enfatizan en el tiempo de duración de este, las frecuencias semanales, la prioridad de los escolares, según las particularidades de los trastornos de la comunicación y el

lenguaje, las edades tempranas, los grados terminales para el tránsito a la educación primaria, las condiciones del aula o gabinete logopédico, los documentos para el control y evaluación de los escolares, en el horario de tratamiento logopédico y forma de organización grupal.

Las referidas autoras precisan los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, que se manifiestan en cada momento del tratamiento logopédico: introducción, desarrollo y conclusiones con el ánimo de mejorarlo desde el enfoque preventivo.

En la introducción, consideran importante la creación de condiciones para la continuidad de esta actividad, la motivación y la orientación del objetivo, criterio que se comparte. Es válido señalar que la motivación debe lograrse en todo el tratamiento, en un ambiente afectivo para los escolares. El control de la tarea pudiera o no realizarse en este momento, según la concepción de las acciones a desarrollar.

En el desarrollo, precisan los contenidos a tratar, referidos a la ejercitación funcional de los órganos articulatorios, al trabajo con la pronunciación, según niveles de articulación, la selección del material verbal, en diferentes situaciones comunicativas, que favorecen la comunicación, el apoyo al currículo del grado, las relaciones interdisciplinarias para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

En las conclusiones, estas autoras, contemplan la valoración de la actividad, la tarea y la despedida. La evaluación constituye un momento esencial al finalizar el tratamiento logopédico, orienta la próxima actividad y debe prevalecer durante este. Otro aspecto que consideran en las conclusiones es la tarea que *“...debe ser de estricto cumplimiento y los padres deben insistir en su realización”* (Fernández, G. y Rodríguez, X., 2012:34),

criterio que se comparte y se considera debe estar en función del objetivo, de las necesidades y potencialidades de los escolares, como parte de la preparación de las condiciones para el próximo tratamiento logopédico.

A pesar de profundizarse en la organización, estructura y contenido del tratamiento logopédico, hay que considerar elementos teóricos y metodológicos no explicitados desde la didáctica general y de la lengua, en el hecho de integrar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua (comprensión, análisis y construcción de textos), las dimensiones del discurso, los procesos del habla y la escucha, con la utilización de recursos metodológicos para favorecer el desarrollo de la comunicación oral.

Las indagaciones teóricas y empíricas acerca del tratamiento logopédico que se realiza en la práctica pedagógica revelan la necesidad de profundizar en su concepción y estructura didáctica, a partir de sus fines en coherencia con el diagnóstico y la intervención logopédica.

1.2.1- El tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario.

La categoría comunicación ha sido objeto de estudio por diferentes disciplinas científicas y enriquecida por los aportes de prestigiosos investigadores desde diferentes ciencias como la Psicología, la Pedagogía, la Lingüística: S. L. Rubinstein (1966); A. R. Luria (1982); Z. M. Sorín (1984); L. S. Vigotsky (1989); B. Lomov (1989); F. González (1995); E. Ortiz (1996); V. Ojalvo (1999); V. González (2002); J. V. Betancourt, (2003); A.

Roméu (2003); L. Rodríguez, (2005); L. M. Sales (2004); F. Martínez (2004); M. Rodríguez y C. Reinoso (2004); I. Domínguez (2007); A. Díaz (2007); J. R. Montalvo (2010); T. Sevillano (2011), entre otros.

Al analizar la concepción de la categoría comunicación por los referidos autores, se encuentran referencias comunes que permiten distinguir ideas esenciales para su comprensión: interacción entre las personas, intervienen múltiples elementos en función de las necesidades de relación del individuo, intercambio de información, ideas y afectos con ayuda de diferentes medios; constituye un elemento trascendental en el funcionamiento y la formación de la personalidad.

La comunicación oral, formada por una serie de signos que se emiten verbalmente, lenguaje hablado, que recibe influencia de la comunicación extraverbal y se vale del canal del habla para efectuarse. *“Este proceso requiere de un emisor, un perceptor, un código, un canal y un mensaje. En la lengua hablada se identifica con las habilidades comunicativas de escuchar y hablar”* (Sales, L. M., 2007:3).

R. Cabanas expresa que la comunicación oral *“...es aquella en la cual un mensaje, concebido mediante los complejos procesos corticales superiores del sujeto codificador, viaja en forma de energía nerviosa por la vía motriz (eferente) y al llegar a los órganos fonoarticulatorios los movimientos de los músculos de estos últimos lo convierten en ondas acústicas específicas, las que, propagándose a través del medio aéreo, alcanzan los receptores auditivos periféricos del sujeto decodificador y, transformándose nuevamente en energía nerviosa, siguen esta vez la vía sensorial (aferente) hasta*

*arribar a las zonas corticales correspondientes (temporales), donde es recibido y comienza su comprensión” (1979:14).*

En esta definición, se reconoce el mecanismo fisiológico de la comunicación oral, sus bases biológicas, que desde el enfoque histórico cultural, constituyen premisas del desarrollo de la personalidad, las que tienen en cada escolar un matiz particular.

G. Fernández y X. Rodríguez plantean que *“...la comunicación oral es un proceso complejo, donde el lenguaje ejerce un papel primordial, por cuanto comunicar es hacer partícipe al otro de nuestros conocimientos, es transmitir, compartir, interactuar, comprender y ser comprendido” (2012:34).* Estas autoras destacan sus componentes: informativo, interactivo y perceptivo, además reconocen los procesos de habla y escucha en la comunicación oral

La comunicación oral es un proceso complejo de interacción entre factores biológicos, psicológicos, lingüísticos, sociales y pedagógicos, que se evidencia en las relaciones del hombre con la naturaleza y la sociedad en la actividad.

Las adquisiciones de la primera infancia relacionadas con el desarrollo de la comunicación oral presentan insuficiencias que contrastan con la preparación que estos deben poseer para su entrada a la escuela primaria. En el primer ciclo de este nivel educativo se debe dar continuidad a las acciones correspondientes a la estimulación temprana, a partir de los servicios especializados del maestro logopeda.

En la práctica educativa la comunicación oral no se reduce a un proceso de mera transmisión de información, sino al papel de la interacción, de la elaboración conjunta de



significados entre los participantes en la actividad como característica esencial del proceso de enseñanza aprendizaje.

El tratamiento logopédico dirigido al desarrollo de la comunicación oral, debe considerar el enfoque histórico cultural, en el que se expresan ideas claves para la prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Según L. S. Vigotsky, el desarrollo humano es un “...proceso dialéctico, complejo, que se caracteriza por una periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo de distintas funciones, por las metamorfosis o transformaciones cualitativas de unas formas en otras (...) por la entrelazada relación de los factores internos y externos” (1989:151).

Desde estas ideas la dimensión preventiva adquiere una connotación especial, precisa determinar en cada momento del desarrollo de los escolares, cómo ha sido la evolución de la comunicación oral, cuáles son sus logros y necesidades, qué factores han influido en esto; el entorno en que se desarrollan y cómo interactúan en él para organizar convenientemente el sistema de influencias educativas, que estimule e involucre a los escolares en su propia transformación.

Los escolares, en la medida que transitan por los diferentes grados de la Educación Primaria, según G. Arias (2003), deben comunicarse con claridad, al comunicar los pensamientos con toda su integridad; con propiedad, al emplear voces que expresan exactamente lo que se quiere decir; con naturalidad, al expresarse sin afectación ni artificio y con expresividad, al emplear la fuerza y entonación adecuada al contenido de lo que se dice en cada momento.

Las ideas de la referida autora son muy importantes desde la dimensión preventiva por el hecho de revelar la estimulación del desarrollo de la comunicación oral en relación con las adquisiciones de los escolares en los diferentes momentos de su desarrollo en cuanto a calidad y volumen del vocabulario, coherencia en las ideas para el dominio de la lengua materna.

Según investigaciones de Rivers, Temperley (1978) y Gauquelin (1982), citados por Cassany, Luna y Sanz (1997), las personas dedican el 80% del tiempo a actividades comunicativas (escuchar 45%, hablar 30%, leer 16% y escribir 9%). Al decir de L. Sánchez (2004), entre los factores que inciden en el desarrollo de la comunicación se encuentra las limitaciones o carencias en los procesos del habla y la escucha.

El habla y la escucha, son procesos básicos que se desarrollan desde la primera infancia, constituyen mediadores de las interacciones entre el emisor y el perceptor y a su vez permiten conocer el mundo y apropiarse de él, mediante la comprensión y construcción de significados.

*La escucha es el modo de aprendizaje más eficaz, hasta por lo menos el sexto grado de la educación primaria* G Brown y G. Yule (1983:39). Escuchar, implica comprender. La comprensión como proceso implica “...entender, penetrar, concebir, alcanzar, discernir, descifrar, decodificar” (García, E., et al., 1978:42).

De valía para este estudio, resultan las ideas de Cassany, Luna y Sanz, en el año 2007, citados por M. E. Monsalve, al expresar: *“Escuchar implica procesos cognitivos complejos, puesto que se tienen que construir significados inmediatos, y para ello se requiere la puesta en marcha de procesos cognitivos de construcción de significados y*

*de interpretación de un discurso oral” (2009:193).* Estos autores revelan la interacción de los procesos de habla y escucha, en la que participan los sistemas funcionales verboauditivo y verbovocal que actúan como un sistema funcional único. A nivel central se establecen conexiones entre las imágenes acústicas y motrices.

Significativas son las ideas de T. Lynch y D. Mendelsohn, al referir *que “...la capacidad auditiva es un proceso activo y las personas que son buenas al escuchar son tan activas como la persona que envía el mensaje” (2002:193).* El proceso de comprensión implica una respuesta constante, el que escucha no tiene un papel pasivo, sino que suele ser muy activo pues colabora en el intercambio y da a entender de alguna manera que comprende lo que se expresa, por lo que el proceso comunicativo se construye a partir de la relación que se establece entre el emisor y el perceptor en la elaboración del mensaje.

James (1984) y T. Lynch (2002), señalan que el escuchar activo involucra una serie de aspectos que van desde lo más sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros aspectos paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se escucha, además de la entonación, el énfasis, el ritmo y la velocidad con que se enuncia el mensaje, el lenguaje corporal, el contacto visual entre los interlocutores, ser flexibles, tolerantes, evitar prejuicios y conclusiones anticipadas. En este sentido hay que pedirles a los escolares que hablen en voz baja, piensen lo que van a decir, que respeten el criterio de los demás y pidan la palabra para comunicarse.

La deficiente comprensión de la escucha en los escolares puede estar determinada por carencias lingüísticas, así como un insuficiente hábito de escucha, lo cual ocasiona, que estos oyen sin escuchar y tardan en percatarse de la significatividad del mensaje.

Para el desarrollo de la escucha, Cassany, Luna y Sanz, en el año 1997, proponen determinadas microhabilidades a tener en consideración, que son: reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, y retener.

El habla *"...es, en primer lugar y ante todo, un instrumento de interacción social, un instrumento para opinar y comprender. Hablar es en sí mismo un acto de inteligencia y creatividad humana, no es sólo emitir sonidos: es negociar y producir conceptos"* (Vigotski, L. S., 1982:24). Esta idea destaca el valor del habla para la comunicación oral como acto individual y su relación con la comprensión de significados en un entorno social. Por eso, se ha de enfatizar en este proceso desde la primera infancia para no comprometer el futuro desarrollo lingüístico y cognitivo de los escolares.

Los procesos del habla y la escucha se reflejan en el mecanismo del lenguaje, con la participación de los sistemas funcionales verbo-auditivo y verbo-motor, los que se encargan de la comprensión y producción de significados. En la sección central se descifra el mensaje captado en la periferia y se elabora la respuesta adecuada. En él participan los sistemas respiratorio, fonador, resonador, articulatorio; en una acción coordinada para la producción del habla (Fernández, G. y Rodríguez, X., 2012).

Las microhabilidades del habla según Cassany, Luna y Sanz, en el año 2007, son: planificar, conducir el discurso, negociar el significado, producir el texto y considerar aspectos no verbales.

En las microhabilidades que se señalan como partes del habla, no se incluyen algunos elementos como la respiración y la voz, que están presentes en el componente sonoro del lenguaje y tienen gran valor en la oralidad.

La educación de la respiración para el habla tiene un valor sustancial como componente energético para la producción de la voz y sus cualidades, así como para el ritmo, la fluidez y la entonación. La voz permite matizar el contenido de la expresión, el estado emocional y la identidad personal, el timbre constituye el sonido vocal que lo distingue de los demás por su carácter individual e irrepetible. Según R. Cabanas “...es el canal emotivo que traduce los sentimientos” (1979:14). El nivel voz se separa del habla solo para su estudio, ambos convergen en el acto comunicativo.

La escucha y el habla, deben convertirse en herramientas que apoyan la construcción colaborativa de conocimientos y el desarrollo del pensamiento; no funcionan aisladas, se relaciona una con la otra, como base de la comunicación oral.

En una conversación, los papeles de emisor y perceptor suelen intercambiarse; por tanto, se deben realizar actividades de expresión y comprensión oral alternadamente, vinculadas con la comunicación escrita (lectura y escritura), según Cassany, en el año 1997 y A. Roméu, en el 2003, que investigan el proceso de la comunicación.

A. Roméu (2007), expresa que el que escucha, puede tomar nota escrita de lo que oye, o leer oralmente lo que ha escrito, o escribir algunas notas con las ideas más importantes a las cuales se va a referir en su discurso. Es interesante la valoración que realiza Roméu, de la integración de los procesos del habla y la escucha con la lengua

escrita, aspecto esencial a considerar en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario.

El primer ciclo de la Educación Primaria, tiene un valor sustancial para el desarrollo de la comunicación oral, por constituir una etapa propedéutica que le imprime una dimensión preventiva a favor del desarrollo personal y social del escolar primario, el que debe transitar al segundo ciclo con una mejor preparación en el dominio de la lengua materna.

### 1.2.2 El tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.

El tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional ha sido estudiado por autores foráneos como: P. Pascual (1981); A. Sos y M. L. Sos (1997); M. V. Reyzábal (1999); J. L. Gallegos y J. R. Gallardo (1993); J. Cañas (2000). En Cuba, se destacan los trabajos de R. Cabanas (1979); M. Martín y otros (1980); E. Figueredo y otros, (1984); G. Fernández (2002); E. Pérez (2003); L. Nikolaevna (2008); G. Fernández y X. Rodríguez (2012), otros.

El término dislalia proviene de los vocablos griego dis, dificultad y lalein, hablar con dificultad. Se utiliza para nombrar aquellos trastornos de pronunciación que se presentan sin otra manifestación acompañante y en presencia de una audición normal. Este es el trastorno del habla más difundido en la población infantil a nivel nacional e internacional (Fernández, G. y Rodríguez, X. 2012:108).

La dislalia constituye un trastorno en la pronunciación de los sonidos porque se produce una desviación de las normas adoptadas por la generalidad de un idioma dado, una vez

surgida no se elimina de forma espontánea, para su corrección exige de procedimientos especiales, influye en el posterior desarrollo de los escolares.

Las causas de este trastorno pueden ser funcionales y orgánicas del aparato articulatorio. A. Sos, M. L. Sos (1997) y P. Pascual (1981) tienen puntos de coincidencias al hablar de las causas de este trastorno, entre las que se encuentran: la escasa habilidad motora, se dificulta la motricidad fina, hay torpeza en los movimientos, falta de coordinación motriz en general y la discriminación auditiva.

Por otra parte, inciden factores ambientales relacionados con la imitación de patrones lingüísticos incorrectos y el bilingüismo mal empleado durante las etapas de evolución y desarrollo del lenguaje.

El trastorno que se produce en la pronunciación de los sonidos puede ser: por omisión: el sonido se omite (“bisa” por “brisa”), sustitución: se reemplaza un sonido por otro (“quiedo” por “quiero”), distorsión: falta de claridad o descuido que da origen a un sonido débil o incompleto (“peggo” por “perro”), adición o añadidura: un sonido que se agrega a la palabra en cualquier parte, se pronuncia (“gusar” por “usar”).

Según P. Pascual (1981), E. Figueredo y otros (1984), I. Padrón y X. Rodríguez (2001), las sustituciones constituyen el tipo de error más frecuente, le siguen las distorsiones, omisiones e inserciones. Al alterarse varios sonidos la expresión oral resulta ininteligible.

La dislalia funcional se caracteriza, según los referidos autores, por la presencia de una insuficiencia motriz o sensorial, de ahí que, se clasifique en dos grupos: dislalia funcional motriz y sensorial. Ambas en ocasiones pueden aparecer combinadas.

La motriz se caracteriza por la torpeza y poca diferenciación de los movimientos articulatorios. El escolar experimenta serias dificultades en el proceso de articulación de sonidos complejos que exigen movimientos exactos y diferenciados.

La sensorial surge en presencia de una audición normal, como resultado de un insuficiente desarrollo del oído fonemático, lo que provoca dificultades en el análisis verbal y se producen alteraciones en la diferenciación de los sonidos, sobre todo los semejantes acústicamente, los pares de sonidos sordos y sonoros /p/- /b/ -/t/- /d/. Puede ser la causa de trastornos en la lectura y la escritura, lo que requiere de una atención especial por el maestro logopeda.

Al considerar el tratamiento logopédico como una actividad pedagógica, se tienen en cuenta los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje: objetivo, contenido, métodos, procedimientos, medios, evaluación y formas de organización.

*El objetivo* es el componente rector del proceso de enseñanza-aprendizaje, son los propósitos y las aspiraciones que durante el proceso se van conformando en el modo de pensar, sentir y actuar del estudiante, es elemento orientador del proceso y responde a la pregunta ¿Para qué enseñar? (Addine, F., 2007).

En el tratamiento logopédico de los escolares con dislalia funcional, el objetivo debe orientarse en función de la etapa de trabajo con la pronunciación, favorecer el desarrollo de las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha.

*El contenido* es aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿qué aprender? Según esta autora se enseña



el resultado de la cultura y lo que se aprende es esa cultura (conocimientos, hábitos, habilidades, relaciones con el mundo, experiencias) (Addine, F., 2007).

Para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, se debe prestar atención a los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua (comprensión, análisis y construcción de textos), estos, facilitan el trabajo con las dimensiones del discurso, los procesos del habla y la escucha, proporcionándole a los escolares la posibilidad de interactuar en diversos contextos socioculturales.

En este sentido la creación de situaciones comunicativas en el tratamiento logopédico contribuye a la comprensión y construcción de textos orales con diferentes intenciones y finalidades comunicativas, lo que permite estudiar su estructura y pone a los escolares en situaciones de interacción en contextos reales o imaginados.

La comprensión del texto como parte del contenido de esta actividad, se manifiesta cuando los escolares expresan, en apretada síntesis, la esencia de lo que el autor quiso significar. Para ello, el maestro logopeda, debe realizar preguntas reproductivas y productivas que permitan construir nuevos conocimientos, en correspondencia con los niveles de comprensión (traducción, interpretación y extrapolación), de esta forma, los escolares pueden expresar con sus palabras el significado del texto, emitir valoraciones sobre el mensaje que reciben y aplicarlo a otros contextos.

En la comunicación oral, una condición para la comprensión del mensaje es el uso de los medios no verbales por parte del emisor, estos tienen responsabilidad en la

transmisión de significados; por ello, es importante el modelo comunicativo del maestro logopeda y el resto de los agentes de socialización; es decir, qué dice y cómo lo dice.

El análisis del discurso *“...es el componente mediatizador, a partir del cual el escolar descubre la funcionalidad de las estructuras discursivas, adquiere los conceptos, se familiariza con el metalenguaje indispensable para poder referirse a los códigos, formas elocutivas, medios léxicos y gramaticales que caracterizan el discurso”* (Roméu, A., 2003:55).

*“La enseñanza del análisis comprende la descripción y explicación de las estructuras textuales (sintaxis), en función de lo que se quiere significar (semántica) y el contexto sociocultural en el que se significa (pragmática)”* (Roméu, A., 2003:65). Su aplicación en el tratamiento logopédico facilita la enseñanza de la lengua materna en su uso funcional y el desarrollo de las dimensiones del discurso como sistema lingüístico.

Ch. Morris, citado por H. Ocaña, distingue las dimensiones del discurso siguientes: *“...la semántica tiene que ver con la relación entre el signo y el referente de la realidad extralingüística a la que remite, la sintaxis se refiere a la relación que se establece entre los signos y la pragmática atiende la relación entre el signo y el intérprete”* (Morris, Ch, Apud Ocaña, H. 2013: 178).

Para el autor de referencia, el emisor parte de la semántica (lo que se quiere significar), tiene en cuenta la pragmática (en qué contexto se va a significar) y la sintáctica (cómo lo va a expresar).

La construcción es un proceso de significación que toma como sustento los conocimientos y experiencias previas que el escolar ha acumulado para comunicar

diferentes discursos, en los que evidencia el desarrollo alcanzado y la influencia del contexto sociocultural. Se logra en la medida en que el escolar comprende la significación de los códigos y construye mensajes con diferentes formas de comunicación.

Tanto la comprensión como la construcción implican producir significados. El tratamiento a estos procesos, según A. Roméu, exige dotar a los escolares de conocimientos y habilidades sobre el uso de estrategias para la búsqueda, evaluación y utilización de la información. Se considera que las estrategias: *“...son instrumentos de la actividad cognoscitiva, que permiten al sujeto determinada forma de actuar sobre el mundo, de transformar los objetos y situaciones”* (2003:72).

Estas estrategias son: inferencias, complementan la información; muestreo, permiten seleccionar la información relevante y predicción, mediante ella se anticipa el texto. En general, facilitan a los escolares resumir ideas esenciales, seleccionar palabras claves, inferir el título de una lectura, el final de un cuento, resumir, expresar la comprensión de lo escuchado con el apoyo de otros códigos.

*El método de enseñanza* está estrechamente relacionado con el objetivo y el contenido, responde a las preguntas ¿Cómo desarrollar el proceso?; ¿Cómo enseñar?, ¿Cómo aprender? Representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías y modos de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes o como reguladores de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes, dirigida al logro de los objetivos (Addine, F. 2007).

En el tratamiento logopédico se utilizan métodos a partir del respeto a la condición del desarrollo de la persona: la conversación, explicación, demostración, la observación de la posición de los órganos articulatorios, entre otros.

*Los procedimientos* complementan a los métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador (Addine, F. 2007). Estos pueden ser la imitación de posiciones articulatorias, de la pronunciación de los sonidos, la ayuda mecánica, la dramatización, lectura expresiva y el uso de expresiones corporales.

Tanto los métodos como los procedimientos, deben utilizarse en correspondencia con el objetivo y los contenidos propuestos, a partir del diagnóstico logopédico de los escolares y las etapas de trabajo con la pronunciación (instauración, automatización y diferenciación de los sonidos de la lengua).

*Los medios de enseñanza* son los elementos facilitadores del proceso, responden a la pregunta "¿Con qué?" y están conformados por un conjunto, con carácter de sistema, de objetos reales, sus representaciones e instrumentos que sirven de apoyo material para la consecución de los objetivos (Addine, F. 2007). Durante todo el tratamiento logopédico los medios deben estar en correspondencia con el objetivo y el contenido de este, así como con el eje temático que se desarrolla.

*La evaluación* es el elemento regulador. Responde a la pregunta ¿En qué medida han sido cumplido los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Conducen a la toma de decisiones y de reorientación, cuyo propósito esencial es el mejoramiento de la calidad de la educación (Addine, F., 2007).

El maestro logopeda debe propiciar entre los escolares la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación de forma crítica, en una relación de amistad, afectiva, participativa, en un ambiente de trabajo conjunto, a partir de criterios, indicadores que les permitan conocer por qué se evalúan de muy bien (MB), bien (B) o regular (R), en correspondencia con las actividades realizadas. Una vez que los escolares se hayan evaluado, el maestro logopeda realiza la evaluación final del colectivo e individual de cada escolar. Es importante que estos adquieran conciencia de lo que han logrado con respecto al objetivo propuesto.

La forma de organización refleja las relaciones entre el profesor y los estudiantes y en la dimensión espacial del proceso. Es el componente integrador y se resume en la manera en que se ponen en interrelación todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. Se debe potenciar el trabajo con las formas colectivas de tratamiento logopédico, para desarrollar sentimientos de colectivismo, camaradería y las relaciones interpersonales.

La organización, planificación, ejecución y control del tratamiento logopédico se diseña sobre la base de los resultados de la exploración logopédica, el análisis del expediente acumulativo del escolar con la caracterización individual y grupal que realiza la maestra en el aula, la entrevista a la familia, maestros, diferentes especialistas del contexto educativo y médico, en el caso que lo requiera y la observación directa a los escolares en clases y otras actividades del proceso docente educativo. Esta actividad pedagógica tiene lugar en los meses de octubre a mayo. Los escolares con mayores dificultades en la pronunciación de los sonidos, reciben una mayor frecuencia semanal.

P. Pascual, J. L. Gallego, R. Gallardo (2000); G. Fernández (2003, 2008, 2012), M. Pons (2012), reconocen la importancia del tratamiento logopédico desde las primeras edades, por las adquisiciones que se producen en el desarrollo de los escolares.

El maestro logopeda, en la solución de los problemas profesionales de la práctica educativa, ha de utilizar variedad de recursos metodológicos que le permitan brindar una atención de calidad a la diversidad de escolares que reciben tratamiento logopédico.

### 1.3 Los recursos metodológicos en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.

Los recursos metodológicos han sido estudiados por diferentes autores, con diversas denominaciones como: recursos metodológicos, didácticos, educativos, informáticos, herramientas, recursos para el aprendizaje, según la intencionalidad para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la educación infantil, autores como S. Urbina (2003), G. Pere (2000-2011) conciben los recursos con un carácter didáctico y los caracterizan como variables metodológicas, que tienen su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

G. Pere (2000-2011), hace una diferenciación entre los medios didácticos y los recursos educativos, toma como criterio de referencia la creación de los medios y recursos con intencionalidad didáctica, al respecto define: "...el medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro de texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química (...); un recurso educativo es cualquier material que, en un contexto

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas” (<http://www.pedagogía.es/recursos-didácticos/>).

J. G. Cárdenas (2003), al referirse a los medios y recursos didácticos, expresa que son todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. Al hablar de manera concreta de los medios tecnológicos informatizados, este autor plantea que: pueden considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos.

Otros criterios a tener en cuenta son los expresados por A. Spiegel, quien los señala como: “...herramientas para enseñar, aprender y evaluar” (2006:5) y F. Reyes, al referirse a los recursos didácticos plantea que son un “*Conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento*” (2007:1).

M. Vidal y C. R. del Pozo refieren que “...para la educación médica, la denominación más abarcadora es la de recursos para el aprendizaje; pues no solo considera como medios a las imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionen para el proceso docente, sino que se convierten en recursos del aprendizaje también los objetos y sujetos del proceso de trabajo y la palabra, el profesor, los alumnos, los pacientes, la familia, la comunidad, el medio ambiente, los medios diagnósticos y otros” (2008:10).

Por otra parte, I. Fernández y G. Vázquez (2008), desde la visión de la tecnología educativa consideran los recursos metodológicos como un conjunto de herramientas tecnológicas (didácticas, pedagógicas, psicológicas, técnicas, operacionales, motivacionales) que facilitan la consecución de los propósitos del trabajo logopédico. También hacen referencia a que pueden ser apoyos y/o ayudas.

S. Guerra (2009), plantea que los recursos metodológicos constituyen distintas vías para atender las particularidades de los escolares, en ellas se revelan los modos de actuación profesional y los procedimientos a seguir en la práctica educativa de carácter flexible. Esta autora hace énfasis en los modos de actuación, elemento importante a considerar en el tratamiento logopédico, por el modelo comunicativo que debe desarrollar el maestro logopeda con los escolares.

Al reflexionar acerca de las consideraciones de los autores de referencia, se debe destacar el hecho de tener en cuenta en los recursos didácticos, el proceso de mediación del otro y el modelo comunicativo de los agentes de socialización.

Por otra parte, V. Guirado (2009), reconoce los recursos didácticos como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas.



La referida autora clasifica los recursos didácticos en cuatro áreas según los sustentos teórico, metodológico y operativo. Por el soporte interactivo: son personales (todas las agencias socializadoras del entorno del escolar) y materiales. Estos últimos, a su vez los subdivide en materiales impresos (libros de texto, libros de consulta y la prensa), materiales audiovisuales (videos, radiocasetes, DVD, retroproyector y el cine) y materiales informáticos.

Según la intención comunicativa los clasifica en interactivos como: software educativo, juegos de mesa, de roles, hipertexto, la conversación, entre otros; informativos como carteles y señales diversas. Además, en organizativos, se refieren a la gradación e individualización de las actividades.

Otro criterio utilizado fue la fuente de obtención, los clasifica en convencionales (interactivos, informativos, organizativos y materiales) creados con fines didácticos y los no convencionales, que no han sido concebidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que en dependencia de su utilización se convierten en herramientas del conocimiento.

También, según su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los clasifica en recursos didácticos para la programación, la activación, la orientación, el enlace, la conducción, la reflexión y evaluación.

Esta autora, se refiere a una variedad de recursos que deben utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen un carácter de mediadores y se considera la atención a la diversidad para elevar la calidad de las respuestas educativas según el contexto, las potencialidades y necesidades de los escolares.

Los autores consultados, denominan los recursos como didácticos, al centrarse en su relación con los medios y en su función principal, sin referirse a cómo pueden ser utilizados en un contexto educativo específico.

Resulta interesante la definición planteada por L. Bolaños (2010) al considerar que los recursos metodológicos propician una forma de proceder para enseñar. En este sentido los define como los medios, procedimientos y formas que emplea el docente para enseñar.

La autora enfatiza en los recursos metodológicos a partir de los procedimientos, formas y medios en general que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, en las manifestaciones concretas de las regularidades didácticas, de las prácticas metodológicas particulares. En este sentido, es oportuno señalar las consideraciones de O. Ginoris; F. Addine y J. Turcaz (2006), al destacar que las nuevas experiencias metodológicas desarrollan y enriquecen la teoría de la didáctica general y se construye teoría didáctica sobre la práctica metodológica particular.

En la investigación se asume el criterio de L. Bolaños (2010) al referirse a los recursos metodológicos en un contexto particular. En este caso, en el tratamiento logopédico, uno de los recursos metodológicos fundamentales lo constituye el maletín del maestro logopeda, que se considera una maleta que sirve para guardar medios, procedimientos, técnicas logopédicas y psicológicas, de uso profesional, en función del diagnóstico e intervención logopédica.

Forman parte de este recurso metodológico otros como: el espejo individual, instrumentos musicales, objetos reales, tarjetero de pronunciación, tarjetas ilustradas,

láminas, tarjetas con antónimos y sinónimos, adjetivos; libros de cuentos, textos, juegos, rompecabezas, el componedor individual, tiras gráficas, sondas logopédicas, hojas de trabajo, lápices de colores o crayolas, tarjeta perforada, de secuencias y acciones, cuarto excluido, entre otros.

Existen otros que no forman parte del maletín del maestro logopeda y se emplean en el tratamiento logopédico, estos son: la observación e imitación de posiciones articulatorias, imitación de sonidos onomatopéyicos y ruidos, discriminación de sonidos de instrumentos musicales, de la naturaleza, de sonidos inarticulados, de vocales y consonantes en diferentes posiciones dentro de la palabra, localización de la fuente sonora, la observación de la respiración, las praxias articulatorias, los juegos de discriminación de sonidos y ruidos, de localización de la dirección del sonido, de imitación de secuencias rítmicas, de imitación de sonidos vocálicos y consonánticos, los ejercicios respiratorios, entre otros, contribuyen al desarrollo de las bases funcionales para el habla y la escucha.

Aumentar y disminuir el tono vocal, la repetición de combinaciones silábicas, el alongamiento de sonidos y vocales, la pronunciación de sílabas y sus combinaciones de golpe, aumentar y disminuir la intensidad vocal, la técnica de la inflexión y la entonación son recursos metodológicos que permiten el desarrollo de las cualidades de la voz.

El análisis discursivo funcional, el sistema de preguntas, las situaciones comunicativas surgidas o planificadas, las estrategias de muestreo, predicción e inferencias, la descripción de objetos, láminas, la segmentación oral de palabras, frases y oraciones, el completamiento de frases y oraciones, la lectura expresiva, la escucha con respuestas

cortas y más extensas, el ordenamiento de secuencias y acciones con apoyo de consignas, la narración de cuentos con una estructura, el uso de expresiones en otros códigos (gestos, movimientos, dibujo), la conversación, resumir ideas de forma sencilla, favorecen el desarrollo de las dimensiones del discurso, así como la comprensión, el análisis y la construcción de textos orales.

Existen otros recursos metodológicos a considerar, el modelo comunicativo del maestro logopeda y demás agentes de socialización, las vivencias de los escolares, la ayuda de los otros, las orientaciones al maestro de aula y la familia, benefician la motivación de los escolares por el tratamiento logopédico y su seguimiento en el contexto del aula y la familia. La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, permite que los escolares reflexionen sobre los aspectos más logrados y en los que deben enfatizar.

El empleo de la diversidad de medios, procedimientos, formas y maneras de enseñar en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares con dislalia funcional, revela la significación que tiene en la práctica pedagógica el mejoramiento de esta actividad en el quehacer del maestro logopeda.

En coherencia con lo anterior, es útil reconocer las ideas planteadas por L. Rodríguez respecto al enriquecimiento de la lengua como eje transversal del currículo al expresar: “Si al llegar a la escuela el alumno ya posee el sistema fonológico de su lengua, los aspectos esenciales de la gramática y ‘suficiente léxico’, es imprescindible considerar que la escuela tendrá que enriquecer y perfeccionar cada uno de esos elementos” (2005:10).

La autora destaca el papel de la escuela en el desarrollo de las dimensiones del discurso para el dominio de la lengua materna, en el que el maestro logopeda en su accionar con el resto de los agentes educativos, gestiona de forma permanente la búsqueda de recursos metodológicos para elevar la calidad del tratamiento logopédico.

### *Conclusiones del capítulo*

El estudio teórico realizado y la experiencia de la autora como maestra logopeda y profesora de esta especialidad, durante más de diez años en la formación inicial y permanente; evidencia la necesidad de enriquecer el tratamiento logopédico, desde el punto de vista de la didáctica general y en particular de la lengua materna, donde deben integrarse las dimensiones del discurso con los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua y los procesos del habla y la escucha; todos liderados por la dimensión preventiva que tiene en cuenta los enfoques de diagnóstico, ontogenético y estimulador del desarrollo para favorecer la calidad del tratamiento logopédico, con el apoyo de recursos metodológicos que contribuyen a tales fines.

## **CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO LOGOPÉDICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DEL ESCOLAR PRIMARIO CON DISLALIA FUNCIONAL**

La sistematización teórica y las posiciones asumidas sobre el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, referidas en el capítulo I, permitió profundizar en el objeto que se investiga. En el capítulo II, se caracteriza el estado actual de este proceso, con la operacionalización de la variable, el análisis de los resultados del diagnóstico inicial, se fundamenta la metodología y se constata su aplicación en la práctica pedagógica.

2.1- Operacionalización de la variable: tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.

Con el propósito de constatar el estado actual del objeto de estudio y su campo de acción, se realiza una definición operativa que facilita la comprensión de los elementos necesarios y suficientes en la determinación de las dimensiones y los indicadores. Se asumen los criterios de D. González y N. Valcárcel (2001), quienes precisan desde el punto de vista metodológico los elementos esenciales que deben distinguir a las dimensiones e indicadores para su operacionalización en función del objeto que trate. Por ello, las conciben como aquellos rasgos que facilitarán una primera división dentro del concepto; es decir, las diferentes partes o atributos a analizar en un objeto, proceso o fenómeno expresado en un concepto, o simplemente diferentes direcciones del análisis.

Por otra parte, estos autores al referirse a los indicadores señalan que son datos operativos medibles, que expresan las manifestaciones externas del objeto, también puntualizan que pueden ser medidos en la práctica, mediante determinados criterios de medidas y categorías entendidas éstas últimas como un continuo de valores ordenados correlativamente que puede admitir un punto inicial y otro final.

En coherencia con estos criterios se precisa la definición operacional de la variable, la que se explicita en el (anexo 1) con la determinación de las dimensiones e indicadores para dirigir esta actividad pedagógica.

*Variable: Tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional. Se concibe como una actividad pedagógica en la que el maestro logopeda con apoyo de recursos metodológicos, a partir de la función cognitiva-instrumental, docente-metodológica y de orientación educativa, integra los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua, así como las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha para la corrección y/o compensación de la dislalia funcional.*

En ella se determinaron tres dimensiones: la cognitivo instrumental, docente-metodológica y de orientación educativa. En las que se evidencian los saberes del maestro logopeda para la concreción de esta actividad, con la preparación teórico-metodológica que exige, a partir de un clima afectivo favorable, con el empleo de los recursos metodológicos por los agentes de socialización como el maestro de aula y la familia.

*La dimensión cognitivo instrumental* se refiere a los conocimientos y habilidades que debe poseer el maestro logopeda acerca del tratamiento logopédico, en el que se integran los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso, con énfasis en los procesos de habla y escucha para el desarrollo de la comunicación oral, desde una visión preventiva del proceso educativo, así como de los recursos metodológicos que se emplean para este propósito. Se determinaron como indicadores los siguientes:

1. *Dominio del tratamiento logopédico.* Se expresa en el conocimiento que tiene el maestro logopeda de la estructura del tratamiento logopédico (introducción, desarrollo y conclusiones), la precisión del diagnóstico logopédico, de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y las dimensiones del discurso.
2. *Dominio de los procesos del habla y la escucha.* Se refiere al conocimiento que tiene el maestro logopeda de de los procesos del habla y la escucha y sus bases funcionales.
3. *Dominio de los recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación oral.* Se manifiesta en el conocimiento que tiene el maestro logopeda de los medios, procedimientos y formas para el desarrollo de la comunicación oral.

*La dimensión docente-metodológica:* se refiere a la aplicación del proceder metodológico en el tratamiento logopédico, donde se integran los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso y los



procesos del habla y la escucha, así como la utilización de los recursos metodológicos que favorecen el desarrollo de la comunicación oral en estos escolares. Se seleccionaron los indicadores siguientes:

*1. Planificación del sistema de tratamientos logopédicos.* Se refiere a la integración de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha por su valor metodológico para el desarrollo de la comunicación oral.

*2. Creación de condiciones para el desarrollo del tratamiento logopédico.* Se evidencia en la selección del material verbal, motivación de los escolares y el desarrollo de las bases funcionales del habla y la escucha.

*3-Tratamiento metodológico a los procesos del habla y la escucha.* Se refiere a la aplicación de estrategias de comprensión y construcción de textos para el desarrollo del habla y la escucha y el empleo de otros recursos metodológicos.

*La dimensión orientación educativa* está dirigida al clima afectivo, la ayuda, el seguimiento que se brinda a los escolares en el tratamiento logopédico y a los agentes de socialización para el desarrollo de la comunicación oral.

*1- Modelo comunicativo del maestro logopeda.* Se evalúa si el lenguaje que utiliza el maestro logopeda es claro, preciso, en correspondencia con la edad y grado de los escolares, que le permite orientarlos en la actividad de forma correcta, si constituye un patrón a imitar.

*2- Ambiente emocional.* Se expresa en la motivación para el tratamiento logopédico y en la concientización de las habilidades alcanzadas por los escolares en un clima afectivo.

*3- Relaciones de ayuda que establece con los escolares y agentes de socialización.* Se refiere a los distintos tipos de ayuda y seguimiento que realiza el maestro logopeda con los escolares, el maestro de aula y la familia.

Las tres dimensiones y sus correspondientes indicadores permitieron interpretar y valorar los datos obtenidos en las indagaciones empíricas para caracterizar la situación actual del tratamiento logopédico, dirigido al desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, de los grados iniciales.

## 2.2. Valoración del proceso y los resultados del diagnóstico inicial.

En el estudio realizado se hace un análisis documental (anexo 2), se aplica la técnica de exploración logopédica a los escolares primarios (anexo 3), la encuesta inicial a maestros logopedas (anexo 4), la entrevista a maestros de aula y a la familia (anexo 5 y 6), la observación a tratamientos logopédicos (anexo 7). También se hace una triangulación de fuentes para el diagnóstico inicial (anexo 8), el folleto de orientación a maestros logopedas (anexo 9), al maestro de aula (anexo 10) y a la familia (anexo 11), los talleres metodológicos para la aplicación de la metodología (anexo 12), entrevista final a maestros de aula (anexo 13), entrevista final a la familia (anexo 14), el procedimiento de triangulación de fuentes para el diagnóstico final (anexos 15) y la observación final a tratamientos logopédicos (anexo 16).

En el curso escolar 2011-2012, se seleccionaron cinco escuelas primarias de la capital: Valdés Rodríguez, del municipio Plaza de la Revolución, Braulio Coroneaux y Mariana

Grajales del Cerro, Rubén Bravo y Lidia Doce de Marianao, para profundizar en el objeto de estudio. Los criterios de selección del grupo de estudio fueron los siguientes: tener una experiencia profesional de más de 5 años como maestra logopeda en la Educación Primaria, mayor número de escolares con diagnóstico de dislalia funcional, en los grados iniciales y que las edades de los escolares seleccionados estuvieran comprendidas entre 6 y 7 años. En correspondencia con los criterios de selección anteriores, el grupo de estudio está conformado por 25 maestros logopedas, 25 escolares con dislalia funcional, de los grados iniciales de la Educación Primaria, 15 maestros de aula y 15 familias.

En la valoración de los resultados del análisis documental (anexo 2), se constata en el 100% de los expedientes logopédicos las insuficiencias teórico-metodológicas desde la didáctica general y en particular, de la lengua materna, que dificultan la concepción didáctica del tratamiento logopédico. En la exploración logopédica, se aprecian dificultades en el registro de la información como elemento básico para el diagnóstico, se pondera la exploración de la pronunciación con poca información del resto de las dimensiones del discurso, el habla y la escucha se restringen a la pronunciación y la discriminación auditiva, esto incide en la toma de decisiones para el diagnóstico, que carece de elementos explicativos.

La modelación de los tratamientos logopédicos, en los 25 expedientes (100%), se estructura en introducción, desarrollo y conclusiones y el objetivo no se planifica en función de la habilidad a desarrollar por los escolares. En 6 (24%), el material verbal utilizado no siempre se corresponde con el diagnóstico de la comunicación oral de los escolares y el eje temático que se desarrolla. Se omiten algunos componentes

del proceso de enseñanza aprendizaje como métodos y procedimientos, en los 25 (100%), que traen como consecuencia la improvisación al considerar la necesidad de intencionar su empleo en dependencia del objetivo del tratamiento logopédico. La evaluación se planifica de manera formal, y la tarea enfatiza en los aspectos menos logrados.

En cuanto a las dimensiones del discurso, en 25 (100%) de los expedientes logopédicos, es insuficiente la atención a la lengua como sistema, se prioriza el trabajo con la semántica, dedicándose menos tiempo a la sintáctica y la pragmática.

Se evidencia un débil trabajo con las bases funcionales del habla y la escucha porque se ponderan los aspectos curriculares del grado en el tratamiento logopédico. Es insuficiente el dominio y la planificación de estrategias para la comprensión y construcción de textos orales en todos los expedientes logopédicos (100%); así como el dominio de los recursos metodológicos utilizados, se enfatiza más en las narraciones y descripciones, sin una estructura que guíe a los escolares, la conversación con predominio de preguntas encaminadas al desarrollo de un primero y segundo nivel de comprensión.

En las formas de organización del tratamiento logopédico, la que más se utiliza es la colectiva y/o grupal por la frecuencia y masividad del trastorno para ofrecer una atención más directa.

En la libreta de visitas a clases y orientaciones al maestro, en el (100%) se precisa el trastorno de pronunciación (dislalia) y sus manifestaciones, sin embargo, las orientaciones a los maestros a favor del desarrollo de la comunicación oral para el

proceso de inclusión educativa son inadecuadas, solo se dirigen a las etapas de trabajo con la pronunciación y no se hace alusión a los recursos metodológicos que se utilizan para el desarrollo de los procesos del habla y la escucha.

La exploración logopédica a los escolares investigados reveló las regularidades siguientes: De los 25 escolares, 15 pertenecen a primer grado (60%), de ellos 6 (40%) presentan dislalia mixta, 5 (33%) dislalia sensorial, 4 (26%) dislalia motriz y 10 de segundo grado, que presentan dislalia motriz (100%).

Entre los sonidos más afectados se encuentran: /s/, /ʃ/, /r/, /b/, /k/, /g/, /j/. Sustituyen /ʃ/ por /l/ al inicio y medio de palabras, 6 escolares (24%), distorsionan /ʃ/ al inicio y medio de palabras 14 escolares (56%), omiten /r/ en sílabas directas dobles 3 (12%), sustituyen /ʃ/ por /d/ 4 (16%), /k/ por /g/ 4 (16%), /ch/ por /ll/ 2 (8%), /ll/ por /ñ/ 1 (4%) al inicio y medio de palabras, omiten /k/ y /j/ al inicio y medio de palabras 1 escolar (4%), distorsionan /s/ al inicio, medio y final de palabras 5 escolares (20%), sustituyen /s/ por /t/ al inicio y medio de palabras 1 escolar (4%) y /b/ por /d/ al inicio y medio de palabras 2 (8%).

De los 25 escolares, 14 (56%) presentan dificultades en la movilidad de los órganos articulatorios, 10 de segundo grado y 4 de primero, 5 (20%) de los escolares presentan dificultades en la atención auditiva y en el desarrollo del oído fonemático. Además, 6 (24%) escolares tienen dificultades sensoriales y motrices, es decir, una dislalia mixta.

En la respiración, 4 escolares (16%), la realizan de forma entrecortada, superficial, 7 (28%), realizan una respiración bucal, el resto de los escolares inspiran y espiran por la nariz, de forma suave y profunda.

Los escolares (100%), se comunican con un lenguaje coherente, lógico, comprenden el lenguaje que se les dirige. Presentan dificultades para la comprensión del significado global del mensaje y seleccionar las ideas principales, 3 escolares (12%), 8 (30%), necesitan de estimulación para que hablen, son tímidos.

El 100% de los escolares utilizan sustantivos, adjetivos y verbos de uso más común, 15 (60%), presentan dificultades con el uso de antónimos y sinónimos, 5 (20%) en la utilización del plural y singular, infieren el final de un cuento 17 escolares (68%); relacionan un tema nuevo con uno conocido 16 (64%). En cuanto a la sintaxis, de forma general, se corresponde con la edad y grado de los escolares, en algunas ocasiones utilizan incorrectamente preposiciones y conjunciones, que no afectan la coherencia de lo que significan.

Por lo general, son escolares cariñosos, afables, cooperadores, se estimulan por la actividad de estudio, les gusta el juego y la computación.

La triangulación de fuentes constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos; A. Ruiz (1999), considera que es la recogida de datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí y realizar un control cruzado entre diferentes fuentes.

Se empleó la triangulación de fuentes a partir de la encuesta a maestros logopedas (anexo 4), la entrevista a maestros de aula (anexo 5), a la familia (anexo 6) y la observación de tratamientos logopédicos (anexo 7). A continuación se ofrecen los principales resultados por dimensiones e indicadores, los que se representan en tablas y gráficos como parte de la triangulación de fuentes (anexo 8):

*En la dimensión cognitivo instrumental, el indicador referido al dominio del tratamiento logopédico, se valora de inadecuado, se constatan carencias relacionadas con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, sólo refieren objetivo, contenido y medios. Los objetivos no se redactan en función de la habilidad a lograr por los escolares, el contenido está dirigido fundamentalmente a resolver el trastorno de pronunciación y apoyar el currículo del grado, no hacen alusión a los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, en cuanto a las dimensiones del discurso, generalmente se refieren a los aspectos fónico, léxico y gramaticales de la lengua. También, deben mejorar la precisión del diagnóstico explicativo del trastorno. La evaluación se concibe al final del tratamiento y de manera formal.*

Los resultados de referencia se reflejan en las orientaciones al maestro de aula y a la familia para dar continuidad en diferentes contextos de intervención educativa.

*En el indicador dominio de los procesos del habla y la escucha, los resultados se evaluaron de inadecuado porque asocian el habla con la realización individual de la lengua, así como la participación de los órganos articulatorios y la escucha la relacionan solamente con la atención auditiva y la discriminación de sonidos, por lo que restringen*

ambos procesos, implicados en la comprensión y construcción de significados. En el habla reconocen entre sus bases funcionales las praxis articulatorias, no así la respiración, la voz con sus cualidades, el ritmo, la fluidez, la entonación y las expresiones corporales para la comunicación oral.

En las orientaciones al maestro de aula las acciones estuvieron dirigidas al trabajo con la pronunciación, el apoyo a las actividades curriculares y en la familia a repetir palabras, oraciones con los sonidos que se automatizan y discriminarlos en diferentes posiciones, lectura de cuentos, realizar paseos y ejercitar actividades de los programas del grado.

De forma general en este indicador se evidencian las carencias teóricas y metodológicas del maestro logopeda respecto a los procesos del habla y la escucha, los que se minimizan y favorecen poco el desarrollo de la comunicación oral en los diferentes contextos.

*En el dominio de los recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación oral,* la valoración realizada es de inadecuada porque restringen su dominio a la descripción de láminas, narración de secuencias, tarjetas, la conversación, el cuarto excluido, rompecabezas, dictado de palabras y oraciones, entre otros; desde esta lógica se sigue en el tratamiento logopédico y en las orientaciones a los maestros y la familia.

Del análisis anterior se infiere, su incidencia en la toma de decisiones para el diagnóstico y la modelación de la estrategia general de intervención logopédica, en la planificación del sistema de tratamientos logopédicos y en las acciones a realizar por los maestros de aula y la familia para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares.



Los tres indicadores de la dimensión cognitivo instrumental fueron evaluados de inadecuados. Al realizar un análisis de estos resultados, en los que influyen diferentes factores como: la insuficiente preparación en la especialidad, asociada a las fuentes bibliográficas que utilizan en la autopreparación, referida a textos tradicionales, carencias en el empleo de textos relacionados con la didáctica general y la didáctica de la lengua, entre otros.

*En la dimensión docente metodológica, el indicador referido a la planificación del sistema de tratamientos logopédicos, también se valora de inadecuada, en coherencia con lo anterior porque se evidencian dificultades en el empleo del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso como sistema lingüístico y los procesos del habla y la escucha, las que se reflejan en las orientaciones que se brindan al maestro y a la familia, con acciones planificadas que se restringen a la discriminación de sonidos de la lengua, la escritura y pronunciación de palabras, frases y oraciones sencillas, completar frases para trabajar la conjugación del artículo con el sustantivo, género y número.*

*En la creación de condiciones para el desarrollo del tratamiento logopédico, la valoración es de poco adecuada, aunque algunos maestros logopedas contemplan la selección del material verbal, en correspondencia con el eje temático y la etapa de trabajo con la pronunciación, se ha de enfatizar en este aspecto y en la motivación por la actividad como condición necesaria para la intervención logopédica; también se le debe dar continuidad en el contexto del aula y de la familia, estimular los logros de los escolares por pequeños que sean, corregir su pronunciación y potenciar el desarrollo del lenguaje.*

Con respecto al desarrollo de las bases funcionales del habla y la escucha, los agentes de socialización coinciden en los ejercicios para la movilidad de los órganos articulatorios, en la realización del análisis fónico y la discriminación de sonidos en diferentes posiciones dentro de la palabra. Lo anterior refleja carencias en la sistematización del trabajo con la respiración para el habla, la voz, la entonación, el ritmo, la fluidez del lenguaje y el empleo de gestos y expresiones corporales como complemento de la comunicación oral.

*En el tratamiento metodológico a los procesos del habla y la escucha,* los resultados de este indicador se valoran de inadecuados, solo algunos maestros logopedas refieren la aplicación de diferentes estrategias de comprensión y construcción de textos orales, señalan la retención de palabras y frases sencillas, prestar atención auditiva. Los maestros de aula y la familia no hacen referencia a las estrategias.

Los resultados anteriores se reflejan en la entrevista realizada a los maestros de aula y a la familia. Los primeros plantean recibir orientaciones por los maestros logopedas y entre las acciones que realizan para el desarrollo de las bases funcionales del habla y la escucha mencionan: discriminar sonidos de diferentes instrumentos musicales, diferenciar sonidos aislados, en sílabas, palabras y oraciones, mostrarle y exigirle la posición correcta de los órganos articulatorios. Tampoco señalan la respiración y la voz.

Los resultados señalados en este indicador evidencian las carencias teórico-metodológicas del maestro logopeda para potenciar el desarrollo del habla y la escucha como base de la comunicación oral

En la segunda dimensión, *referida al aspecto docente metodológico*, de forma general se valora de inadecuada, aunque tuvo un mejor comportamiento el indicador que hace referencia a la creación de condiciones para el tratamiento logopédico.

*En la dimensión orientación educativa*, en el indicador modelo comunicativo del maestro logopeda, la valoración general es de adecuada, tanto los maestros logopedas, los de aula y como las familias lo consideran como un aspecto importante en el tratamiento logopédico.

En el *ambiente emocional*, la valoración es de poco adecuada, aunque se tiene en cuenta la motivación por la actividad que realizan los escolares, existen dificultades en la concientización de las habilidades alcanzadas en el tratamiento logopédico, se ha de profundizar en la propuesta de nuevas metas para alcanzar los objetivos planteados.

El tercer indicador de esta dimensión, relacionado con la ayuda a los escolares por los agentes de socialización, se hace una valoración de poco adecuado, en este caso, señalan la ayuda mecánica, por la vía de la imitación, o la de otros especialistas, cuando se requiera; sin embargo, no contemplan el sistema de preguntas de apoyo para el trabajo con los diferentes niveles de comprensión de textos, que le permiten desarrollar en los escolares los procesos del habla y la escucha. Los maestros de aula y la familia plantean como ayuda las orientaciones que reciben del maestro logopeda, mediante las libretas de visitas a clases y orientaciones al maestro y la de labor social, en el caso de la familia, no refieren otros tipos de ayuda como la observación de tratamientos logopédicos.

La valoración de *los resultados de la observación inicial a tratamientos logopédicos*, la que se toma como base para el diagnóstico inicial del pre-experimento, el que se analiza a continuación.

El análisis de los resultados del diagnóstico inicial, permite constatar el estado del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar con dislalia funcional, de los grados iniciales de la Educación Primaria. Se seleccionaron 5 (20%) maestros logopedas de manera intencional para profundizar en el objeto de estudio. Se observaron 25 tratamientos logopédicos, cinco a cada maestro logopeda (individuales y colectivos), entre los meses de octubre-mayo del curso 2011-2012.

*En la dimensión cognitivo instrumental, el indicador: dominio del tratamiento logopédico*, en los 25 (100%), se constata el dominio de su estructura. Es inadecuada la integración de los elementos de la didáctica general y en particular de la lengua materna, el diagnóstico carece de elementos explicativos que permiten la diferenciación entre los tipos de dislalia funcional, por su valor metodológico para la intervención logopédica.

Se omiten componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje como los métodos y procedimientos, la evaluación carece de un tratamiento metodológico adecuado al concebirse al final del tratamiento logopédico, de manera formal y no propiciar la coevaluación y la heteroevaluación entre los escolares, lo que atenta contra la concientización de sus fortalezas y debilidades, la tarea se orienta en función de estas últimas, en 13 (52%) de los tratamientos logopédicos, no hay un trabajo sistemático con las dimensiones del discurso como sistema lingüístico.

En el (100%) es insuficiente la atención a la dimensión pragmática del discurso. Es inadecuada la atención a los procesos del habla y la escucha, así como el insuficiente empleo de estrategias para la comprensión y construcción de textos y de los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua. El indicador se evalúa de inadecuado.

*El indicador dominio de los procesos del habla y la escucha, se evalúa de inadecuado, en los 25 (100%) de los tratamientos logopédicos, se comprueba insuficiente dominio del habla y la escucha en los grados iniciales de la Educación Primaria y las estrategias de comprensión y construcción de textos para el desarrollo de estas. Se evidencia una concepción tradicional que privilegia el trabajo con la pronunciación y enfatiza en el apoyo al currículo, hay un débil trabajo con las bases funcionales del habla y la escucha y del empleo de recursos metodológicos con estos fines.*

*El dominio de los recursos metodológicos es inadecuado, los procedimientos y las ayudas utilizadas responden solo a la corrección del trastorno de la pronunciación en 21 (84%) de los tratamientos logopédicos. Se constata la necesidad de enfatizar en la preparación teórica y metodológica en este aspecto, por la necesidad de emplear variados recursos metodológicos que favorezcan el desarrollo de la comunicación oral y lo que esto representa desde una visión preventiva en los trastornos de la comunicación y el lenguaje.*

*En la dimensión docente metodológica, el indicador referido a la planificación de tratamientos logopédicos, se evalúa de inadecuado. En los 25 (100%) de estos, se aprecia insuficiente concreción de las acciones a seguir para el trabajo correctivo*

compensatorio de acuerdo con las necesidades y potencialidades de los escolares, la revisión de la tarea no es sistemática, en solo 5 (20%) de los tratamientos logopédicos observados se revisa la tarea, lo que conspira con la motivación por esta actividad pedagógica. en 15 (60%) de los tratamientos logopédicos, el objetivo no se revela de forma clara en el sistema de actividades, dedican la mayor parte del tiempo a apoyar el currículo escolar. Estos resultados evidencian improvisación en el tratamiento logopédico, en el que se debe revelar la relación entre el binomio diagnóstico e intervención logopédica.

La concreción de acciones para el desarrollo de la lengua como sistema es inadecuada, en los 25 (100%) de los tratamientos logopédicos observados, se presentan insuficiencias en el empleo de las dimensiones del discurso y está ausente la dimensión pragmática, así mismo sucede con el tratamiento metodológico a la comprensión, el análisis y la construcción de textos, lo que permite la enseñanza de la lengua en su uso funcional, a partir de diferentes situaciones comunicativas.

El indicador referido a la *creación de condiciones para el desarrollo del tratamiento logopédico*, se evalúa de inadecuado, aunque en todos los tratamientos logopédicos se brinda confianza, y seguridad a los escolares al motivarlos para la realización de este, en 15 de ellos (83%), se le dedica muy poco tiempo al desarrollo de las bases funcionales del habla y la escucha, condiciones importantes para el desarrollo de la comunicación oral y el material verbal seleccionado no se corresponde, en ocasiones con el eje temático que se desarrolla y en otras con el sonido que se trabaja en las etapas de la pronunciación.

En el *tratamiento metodológico a los procesos del habla y la escucha*, en 20 (80%) de los tratamientos logopédicos es inadecuado, existe insuficiente aplicación de las estrategias de muestreo, predicción e inferencias, que permiten la comprensión y construcción de textos; así como la utilización de los recursos metodológicos, se enmarcan en la descripción de láminas, narraciones de secuencias, cuentos, de hechos de la vida real, lo que demuestra carencias en la variedad de estos.

La dimensión se evalúa de inadecuada por las insuficiencias en todos los indicadores. Al valorar estos resultados hay que considerar varios factores que han incidido. Primero, la inestabilidad del trabajo del maestro logopeda por problemas de cobertura en el sector educacional, la poca sistematización de la superación permanente en la especialidad en el contexto de la Educación Primaria, solo hace dos cursos escolares que se le ha dado continuidad sistemática. Por otra parte, la necesidad de formar maestros logopedas para potenciar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje desde el contexto común, a favor de la prevención como dimensión educativa.

En la dimensión orientación educativa, un logro importante se considera el modelo comunicativo del maestro logopeda, en 22 (88%) de los tratamientos logopédicos se utiliza un lenguaje claro, preciso, en correspondencia con la edad y grado de los escolares, que le permite orientarlos de forma correcta. Su lenguaje constituye un modelo a imitar. Un aspecto a solucionar está relacionado con el ambiente emocional, en 22 (88%) de los tratamientos logopédicos, no se propicia el conocimiento constante por los escolares de las habilidades alcanzadas en un clima afectivo, por lo que se evalúa de poco adecuado.

Con respecto a la ayuda que se brinda a los escolares en 18 (72%) de los tratamientos logopédicos, se evalúa de inadecuada al no contemplarse los diferentes niveles de ayuda, esta se dirige a la demostración y esencialmente se produce con más frecuencia en el trabajo con la pronunciación.

Al realizar una valoración general, se precisan fortalezas y debilidades que caracterizan el estado actual del problema que se investiga, ellas son: el dominio de la estructura del tratamiento logopédico, la motivación para esta actividad, el modelo comunicativo del maestro logopeda al orientar la actividad al escolar y los diferentes agentes de socialización.

Entre las debilidades se señalan: carencias en el dominio de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha por el maestro logopeda. Además, se evidencia poco desarrollo de las bases funcionales para el trabajo con el habla y la escucha, insuficiente tratamiento al proceso de evaluación y el empleo de recursos metodológicos que favorezcan este proceso; lo que incide en el conocimiento de los escolares sobre las habilidades alcanzadas en la actividad que realizan. También, se aprecia una limitada orientación a los agentes de socialización.

A continuación se presenta la figura 1, donde se ilustran los resultados de todos los indicadores como parte del diagnóstico inicial del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral, del escolar primario con dislalia funcional.



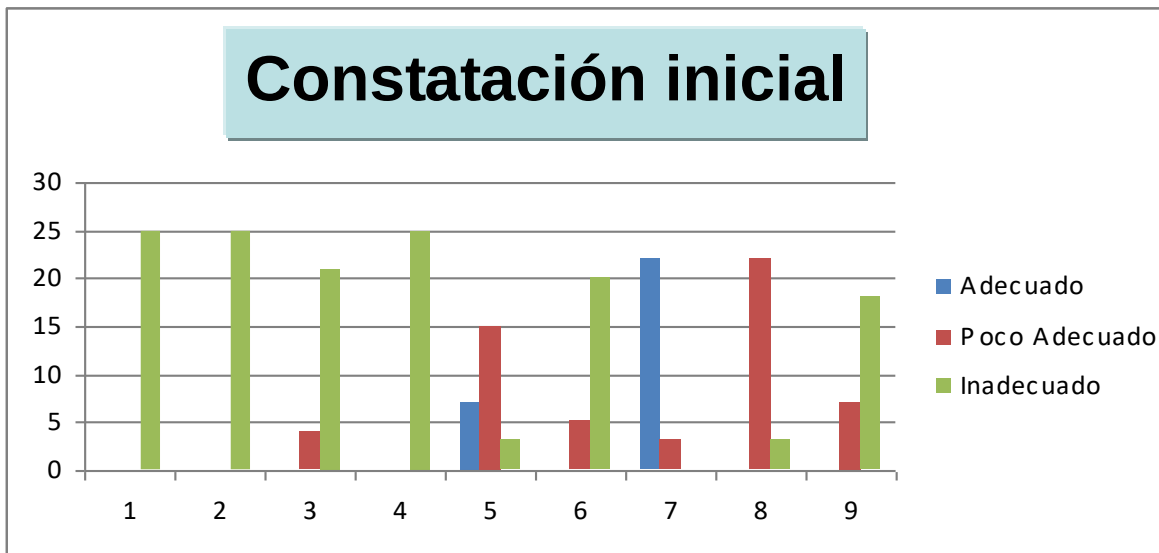


Fig. 1. Diagnóstico inicial de la observación a tratamientos logopédicos.

Los resultados señalados ilustran las insuficiencias que se presentan en la práctica pedagógica en cuanto a la concepción didáctico-metodológica del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral en el escolar con dislalia funcional, de los grados iniciales de la Educación Primaria. Por ello, es pertinente buscar una vía de solución mediante el empleo del método científico, en este sentido el camino seguido para este propósito se concreta en una metodología.

### 2.3- Fundamentación de la metodología. Su estructura y contenido.

En la literatura científica, el concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones que varían según la interpretación que cada quien hace de él. Desde lo filosófico, la metodología se define como: “...la teoría sobre los métodos del conocimiento científico del mundo y la transformación de este” (Rosental, M. y Ludin, P., 1981:317).

Al decir de R. Bermúdez y M. Rodríguez, la metodología es *“...un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas que, regulados por determinados requerimientos o exigencias, nos permiten ordenar nuestro pensamiento y modo de actuación con el propósito de obtener o descubrir nuevos conocimientos en el estudio de un problema teórico o en la solución de un problema en la práctica” (1996:3).*

El colectivo de autores de Villa Clara, integrado por N. de Armas, J. Vázquez, M. Perdomo, J. Lorences (2002), plantean que la metodología es una forma de proceder para alcanzar determinado objetivo, que se sustenta en un cuerpo teórico y que se organiza como un proceso lógico conformado por una secuencia de etapas, eslabones, pasos o procedimientos condicionantes y dependientes entre sí, que ordenados de manera particular y flexible permiten la obtención del conocimiento propuesto.

Al asumir la definición del colectivo de autores mencionados anteriormente, permiten contextualizar la metodología como una forma de proceder, organizada en tres etapas, con sus correspondientes pasos y recursos metodológicos específicos que facilitan el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario, de los grados iniciales con dislalia funcional.

La metodología se sustenta en la dialéctica materialista, donde se articulan desde una concepción interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria las ideas de las ciencias pedagógicas, médicas, psicológicas, lingüísticas, sociológicas y de la didáctica general y las didácticas particulares, el enfoque que rige el tratamiento logopédico: el histórico cultural de Vigotski y sus seguidores (1989), para el desarrollo de los procesos del habla y la escucha.

Los fundamentos de la metodología parten de una visión preventiva del proceso educativo en el tratamiento logopédico, *“...desde la que se ejercen influencias que potencien su calidad, a la vez que se atenúan, disminuyen o evitan aquellas que la afectan, desde una posición consciente y activa de todos sus participantes”* (Rodríguez, R., 2010:15), a partir de los enfoques ontogenético, de diagnóstico y estimulador del desarrollo en la formación del maestro logopeda. La metodología se fundamenta en el enfoque histórico cultural, la didáctica de la lengua y la orientación educativa para cumplir con el fin propuesto.

Desde el enfoque histórico cultural, la metodología se sustenta en fundamentos filosóficos, sociológicos, biológicos, psicológicos, pedagógicos, lingüísticos y didácticos.

Al fundamentar el **punto de vista filosófico**, asume al hombre como una realidad biológica, psíquica, individual, social e histórica, favorece su formación integral, que permite al sujeto que aprende desarrollar su conciencia crítica y llegar a convertirlo en protagonista de su momento histórico, donde este se desarrolla, se transforma con un gran sentido de solidaridad humana, en los proceso de la actividad y la comunicación.

Como parte de los **fundamentos biológicos**, se reconoce el papel de condición de los factores biológicos en el desarrollo humano, en particular en el proceso de la comunicación oral de los escolares con dislalia funcional, expresados en la normalidad de las estructuras de los diferentes órganos y sistemas que intervienen en el habla y la escucha. Se considera que la dislalia funcional surge esencialmente a partir de lo sociocultural.

Desde el **punto de vista sociológico**, la metodología parte de las demandas actuales de la sociedad cubana, para lograr el desarrollo de los procesos del habla y la escucha, como condiciones básicas para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares con dislalia funcional, donde se ponderan las relaciones maestro logopeda-escolares, escolares-escolares. Se trata de lograr la unidad de los agentes de socialización (maestro de aula y familia), para que cada uno, con su forma específica de enseñar y su creatividad, guiados por la orientación del maestro logopeda, contribuyan a la formación de los escolares.

Desde los **fundamentos psicológicos**, se sustenta en el enfoque histórico cultural, que constituye la base teórico-metodológica para la modelación de la metodología. Se tienen presente categorías como: “situación social del desarrollo”, “zona de desarrollo próximo”, “vivencia”, “otros”.

Se asume en la investigación que *“La situación social del desarrollo es, ante todo, la relación del niño con la realidad social, que ocurre mediante la actividad humana”* (Betancourt, J., et al, 2012:22). En la metodología que se propone, se consideran los factores del medio en que se desarrollan los escolares con dislalia funcional. Se brindan orientaciones dirigidas a lograr una adecuada armonía en el sistema de influencias educativas provenientes del medio escolar y familiar, dirigidas a potenciar los procesos del habla y la escucha como bases de la comunicación oral.

De indudable valor metodológico resulta para el tratamiento logopédico el concepto introducido por L. S. Vigotski (1982) de “zona de desarrollo próximo”. Según este autor existe una diferencia entre lo que el niño es capaz de realizar por sí solo y lo que puede efectuar con ayuda de los adultos o de otros compañeros. Lo primero, indica el nivel

evolutivo real del niño, el nivel de desarrollo de las funciones mentales que ya han madurado; es decir, los productos finales del desarrollo, mientras que lo segundo revela aquellas funciones que se encuentran en proceso de maduración.

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo siempre debe estar presente en los métodos de trabajo, en el tratamiento logopédico. Se coloca al escolar en el centro del proceso y se utiliza todo lo que está disponible en el sistema de relaciones más cercano a este, para propiciar su interés y un mayor grado de participación e implicación personal en todos sus aprendizajes. Permite brindar a los escolares la ayuda necesaria a partir del diagnóstico.

El paso de los escolares por diferentes etapas en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral, concibe el tránsito de zonas de desarrollo actuales a zonas de desarrollo potenciales con la mediación del maestro logopeda, los demás escolares y los agentes de socialización.

La categoría vivencia es fundamental en la propuesta de la metodología si se considera que *“...el medio determina el desarrollo del niño a través de la vivencia de dicho medio”* (Vigotski, L. S., 1996: 383), a partir de las experiencias acumuladas por la cultura en un momento histórico concreto para el desarrollo de los procesos psíquicos. Esta categoría tiene un gran valor en el tratamiento logopédico, por su repercusión en la formación de la personalidad de los escolares, por eso es necesario enfatizar en el desarrollo de la comunicación oral como base para el aprendizaje de la lectura y la escritura, así como de las influencias educativas del medio escolar y familiar como determinantes en esta actividad pedagógica.

La categoría “otros” se tiene en cuenta en el tratamiento logopédico, al desarrollarse actividades que favorecen el intercambio continuo entre los escolares y entre estos y el maestro logopeda. Su participación en tratamientos colectivos o grupales, crea espacios de comunicación que favorecen el desarrollo de la personalidad. Sin la presencia del otro, no sería posible para el hombre la apropiación de toda la experiencia histórico-social acumulada.

La metodología se sustenta en los postulados vigotskianos como: la *relación entre educación y desarrollo*, la primera conduce y propicia la segunda, en la metodología se revela en la variedad de recursos metodológicos que se utilizan para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares. La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, que se aplica en todas las etapas de la metodología, desde la creación de un clima emocional afectivo y favorable, que permita una mejor asimilación de los contenidos del tratamiento logopédico por los escolares, los motiva e interesa por esta actividad, eleva su autoestima al reconocérsele sus logros por pequeños que sean.

En correspondencia con la siguiente valoración: *“Todo el desarrollo psicológico del ser humano es el resultado de la mediación que ejercen en el sujeto otras personas, objetos, instrumentos, signos y sus significados, lo que transcurre según los diferentes tipos y formas”* (Betancourt, J., et al, 2012:9), la ley de la mediación del desarrollo psíquico, a partir de la valoración constante de la actividad realizada y la influencia de los maestros de aula y la familia. También, los propios escolares durante el intercambio comunicativo y las ayudas que se le ofrecen.

Por otra parte, la mediación instrumental, con la ayuda mecánica que se brinda a los escolares al no poder pronunciar el sonido por la vía de la imitación, en la medida que el

maestro logopeda, los de aula y la familia se apropian de las posibilidades que ofrecen las herramientas elaboradas (folleto de orientación al maestro logopeda, al de aula y a la familia).

La relación entre la comunicación y la actividad; en este postulado se expresa el vínculo entre estas categorías. Se enfatiza en la consideración de la comunicación como un proceso que se desarrolla en la actividad, en este caso, en la interacción entre el maestro logopeda y los escolares y entre los propios escolares, durante el tratamiento logopédico, lo que favorece los procesos del habla y la escucha.

La unidad entre pensamiento y lenguaje; este principio, tiene un especial significado en la metodología que se propone, por la relación que se establece entre los procesos cognitivos y lingüísticos para el aprendizaje, donde el pensamiento ocupa un papel principal y el significado de las palabras es tanto pensamiento como habla (Vigotski, L. S., 1989).

En este caso se establecen las relaciones entre las dimensiones del discurso y los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua. A. Roméu (2007), señala que este enfoque supone para el docente concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso complejo de elaboración de significados, centrado en la relación texto-contexto, dirigido a que el escolar primario, de los grados iniciales, con dislalia funcional, aprenda a comunicarse en una determinada situación comunicativa.

Desde el punto de vista **pedagógico**, se sustenta en la educación de la personalidad, con lo más elevado del pensamiento pedagógico cubano y los resultados de investigaciones pedagógicas, que asumen los postulados de la escuela histórico-cultural

(M. Silvestre y J. Zilberstein (2000); D. Castellanos y otros, 2002). El profesor es quien organiza, dirige y controla el proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve el papel activo del escolar en la construcción del conocimiento y su autoperfeccionamiento constante, presta atención a la evaluación desarrolladora, lo que se materializa en la metodología al propiciar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación entre los escolares, con la concientización de los aspectos menos logrados en un clima de afecto, camaradería y ayuda que estimula a mejorar la comunicación y el lenguaje.

Desde **la Didáctica General**, se asumen los principios didácticos expuestos por M. Silvestre (2002), que permiten al maestro logopeda dirigir científicamente el desarrollo de la comunicación oral de los escolares en diferentes contextos del aula y la familia. Estos principios son:

- Principio del diagnóstico integral. El maestro logopeda debe dominar las particularidades de la comunicación, psicológicas, pedagógicas, del contexto escolar y familiar para poder realizar una caracterización integral de los escolares, trazar la estrategia de intervención. En la metodología se expresa en la estructuración de las etapas, pasos, las orientaciones y ayudas que se le brindan a los escolares en el tratamiento logopédico y a los agentes de socialización.
- Principio de la búsqueda activa del conocimiento. Se manifiesta en los recursos metodológicos que se utilizan para favorecer la comprensión, el análisis y la producción de textos orales, lo que favorece el desarrollo de las dimensiones del discurso, los procesos del habla, la escucha y las reflexiones constantes de los



escolares acerca de lo que han logrado en el tratamiento logopédico y en qué deben mejorar.

- Principio de la motivación hacia el objeto de la actividad. Está presente en las etapas de la metodología, desde el modelo comunicativo del maestro logopeda en la conversación inicial para motivar a los escolares por el tratamiento logopédico, la concepción de actividades para el desarrollo de los procesos del habla, la escucha y el estímulo constante de sus logros.
- Principio del desarrollo de formas de actividad y comunicación colectivas. Se expresa en la metodología en la creación de situaciones comunicativas surgidas o planificadas que permiten el intercambio comunicativo escolar- escolar y escolar- maestro logopeda, entre otros.
- Principio de la atención a las diferencias individuales. Se manifiesta en la precisión del diagnóstico de los escolares, lo logrado y la ayuda que los escolares pueden requerir a partir de la valoración y autovaloración del resultado de la actividad.

En particular, en los fundamentos de la didáctica de la lengua, la metodología, se sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, construcción teórico-metodológica, al propugnar que *“...la enseñanza del análisis en su dimensión discursiva, comprende la descripción y explicación de las estructuras textuales (sintaxis) en función de lo que se quiere significar (semántica) y el contexto sociocultural en el que se significa”* (Roméu, A., 2003:9).

Su aplicación en el tratamiento logopédico se contempla en el análisis de los hechos lingüísticos a partir de las situaciones comunicativas en la que los escolares interactúan, mediante la comprensión, el análisis y la construcción de textos orales.

Por otra parte, al asumir los componentes funcionales del enfoque tiene en cuenta el desarrollo de las dimensiones del discurso como sistema (semántica, sintáctica y pragmática), porque al decir de T. Van Dijk, esta “...establece vínculos funcionales entre las estructuras del discurso y entre dichas estructuras y el contexto social, y se mueve en el micro y macro nivel de la conversación, del texto, del contexto o de la sociedad y viceversa” (2000:48).

Se sustenta en la orientación educativa, que tiene su base en la concepción teórica desarrollada por B. Collazo (1992, 2011), A. Blanco y S. C. Recarey (1999), J. L. Pino (1998-2011) y S. C. Recarey (2011). Estos autores, defienden la ayuda al escolar para estimular su desarrollo personal, sobre la base de la calidad de la comunicación y la puesta en práctica de actividades desarrolladoras, elementos importantes a considerar en el tratamiento logopédico. Se le concede gran valor a las posibilidades orientadoras del maestro, donde el modelo comunicativo de este profesional, es fundamental.

También asume las ideas de A. García (2011), acerca de la orientación familiar y las de A. R. Padrón (2011), sobre la función del maestro en la educación familiar.

La autora asume la orientación educativa como “...la actividad científica de definir e implementar cómo ayudar con efectividad a alguien en un momento y un espacio dados para facilitarles el mayor nivel de crecimiento personal posible, según la etapa específica

*de desarrollo en que se encuentre y su situación social y personal concreta” (Recarey, S. y Pino, J. L., 2011:72).*

En la metodología, la orientación educativa, se concibe a partir de la comprensión de la unidad entre la escuela y la familia, al reconocer la influencia de estas instituciones, como principales agentes socializadores en la formación y desarrollo de los escolares.

En la orientación educativa como dimensión esencial en la labor del maestro logopeda, desde una intencionalidad preventiva como parte de su accionar con los escolares, los maestros de aula y la familia, se enfatiza en las ayudas que exigen todos para cumplir con el propósito que se aspira: el desarrollo de la comunicación oral, sin sentirse apenados ni culpables ante las dificultades que puedan presentarse. El manejo educativo es fundamental para enseñarles cómo se desarrolla la habilidad de escuchar y hablar como condiciones básicas no solo para pronunciar bien un sonido, sino para dominar adecuadamente su lengua materna.

En este sentido, tanto los maestros de aula como las familias tienen carencias, prioridades y maneras de actuar diversas, es necesario ser tolerantes y negociar de conjunto con la mediación social e instrumental cómo potenciar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje del escolar independientemente de las dificultades. Sin usar tecnicismos, invitarlos al salón de clases y al gabinete logopédico para observar tratamientos logopédicos donde puedan valorar las potencialidades de sus hijos, ello favorece crear un clima de confianza y seguridad para dar continuidad a la labor del maestro logopeda.

El maestro, en su labor educativa debe planear con las familias las formas de ayudarlos, a partir de considerar sus puntos de vista, sus dificultades y deseos. Las soluciones deben estar basadas en las ideas, la creatividad y la fortaleza de la familia. L.P. Castro, et al (2010).

La consideración de estos fundamentos es muy importante para la práctica pedagógica del maestro logopeda, el que desde una visión preventiva debe potenciar el desarrollo de la comunicación oral en estos escolares.

Las particularidades de la metodología según el objeto y el campo de estudio están dadas en el hecho de integrar desde una visión preventiva un sistema de relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso y los procesos del habla y la escucha en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario, de los grados iniciales, con dislalia funcional, las que se evidencian en su estructura y contenido: tiene tres etapas: introducción, desarrollo y conclusiones, con sus correspondientes pasos y recursos metodológicos.

El **objetivo general** de la metodología es profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional.

Las **exigencias metodológicas** que cumple esta metodología son:

1. La concepción de la formación integral de la personalidad del escolar en el tratamiento logopédico.

2. La organización metodológica del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral mediante etapas con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. La aplicación de los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua (análisis, comprensión y producción de textos) y las dimensiones del discurso.
4. El desarrollo de las bases funcionales de los procesos del habla y la escucha (movilidad de los órganos articulatorios, desarrollo de la atención y discriminación auditiva y el componente sonoro del lenguaje).
5. El empleo de recursos metodológicos en el tratamiento logopédico para el desarrollo del habla y la escucha.

La metodología que se propone favorece el aprendizaje de la comunicación escrita y permite prevenir los trastornos que se puedan presentar en su adquisición por los escolares de los grados iniciales de la Educación Primaria, en la medida que estos perciben la estructura fonológica de los textos, descubren el significado de las palabras y las relaciones sintácticas que existen entre estas y reconstruyan el significado sobre la base de los conocimientos que tienen sobre la realidad y los medios fónicos, léxicos y gramaticales.

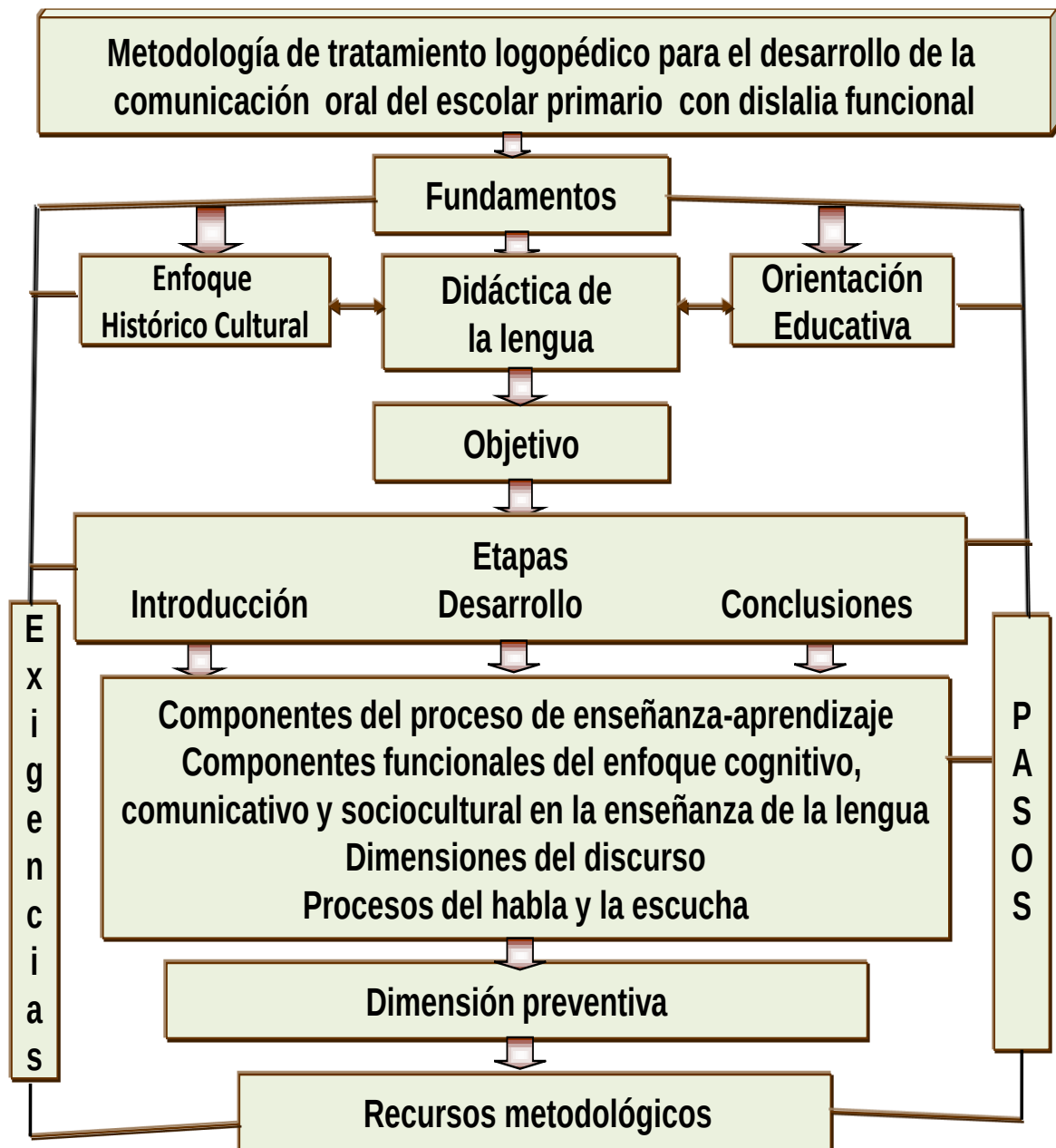
Este resultado científico se caracteriza por el *humanismo*, porque considera a los escolares y agentes de socialización como centro de su atención educativa, la preparación del maestro logopeda, la orientación a los maestros de aula y a la familia, lo

que repercute en el desarrollo de la comunicación oral de sus hijos, como base para la comunicación escrita y la formación de su personalidad.

Es *flexible*, en tanto permite su actualización y rediseño en correspondencia con las necesidades que surjan en la dinámica de su desarrollo. También es *pertinente* porque responde a las necesidades reales de la práctica educativa, un tratamiento logopédico donde se relacione desde el punto de vista didáctico los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso como sistema lingüístico, los procesos del habla y la escucha, con la utilización oportuna y adecuada de los recursos metodológicos, contribuye a favorecer el desarrollo de la comunicación oral.

También se caracteriza por ser *contextualizada*, en tanto se adapta a las condiciones de la escuela, en correspondencia con el Modelo Proyectivo de Escuela Primaria. Su aplicación está precedida por la preparación del maestro logopeda en los talleres metodológicos y en las diferentes formas de trabajo metodológico de la escuela. Las tres etapas que la conforman se evidencian en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral. Por eso, se ha de desarrollar esta concepción integral desde el punto de vista didáctico y preventivo para elevar su calidad a favor de la comunicación y el lenguaje.

La metodología se distingue por revelar un sistema de relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, con los del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, las dimensiones del discurso, los procesos del habla y la escucha y los recursos metodológicos que se ofrecen.



**Fig.2.** Metodología de tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario.

## *Etapas de la metodología*

👉 *Etapa 1. Introducción. Tiene como objetivo la creación de condiciones para el tratamiento logopédico.* El maestro logopeda motiva y familiariza a los escolares con el tratamiento logopédico, le hace conciencia de su importancia para mejorar la comunicación oral.

➤ *Primer paso: motivación inicial para el tratamiento logopédico.*

En este paso, el maestro logopeda emplea recursos metodológicos que posibilitan motivar a los escolares para el tratamiento logopédico como: situaciones comunicativas surgidas (tema libre) o planificadas (conversación a partir de la observación de videos, descripción de objetos y láminas, conversación a partir de fragmentos de lecturas, juegos, narraciones de secuencias, otros), las vivencias de los escolares.

La utilización de estos recursos permite que los escolares se interesen y familiaricen con esta actividad pedagógica, que sientan confianza en el tratamiento logopédico y en sí mismos y los prepare para etapas posteriores.

➤ *Segundo paso: orientación del objetivo.*

Creadas las condiciones, el maestro logopeda, procede a orientar el objetivo del tratamiento logopédico.

En este paso se utiliza como recurso metodológico el modelo comunicativo del maestro logopeda, quien de forma clara, precisa y en consideración de la edad, grado y desarrollo del lenguaje de los escolares, facilita la comprensión del propósito



de la actividad y de las acciones a realizar para su cumplimiento. Ejemplo. Si se trabaja la etapa preparatoria el objetivo puede ser: colocar la lengua en la posición articulatoria adecuada o mover la lengua de diferentes formas, según sea el caso, si se trabaja la instauración del sonido /f/, el objetivo será pronunciar el sonido /f/.

## *Etapas 2. Desarrollo*

En esta etapa el objetivo está dirigido a desarrollar los procesos del habla y la escucha en diferentes situaciones comunicativas que favorezcan la comprensión y construcción de textos orales.

En esta etapa el maestro logopeda desarrolla las bases funcionales para el habla y la escucha, el componente sonoro del lenguaje (voz, respiración, ritmo y fluidez), corrige la dislalia funcional, desarrolla los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua (comprensión, análisis y construcción de textos), las dimensiones del discurso, apoya el currículo del grado y la formación de la personalidad de los escolares, con énfasis en el empleo de recursos metodológicos para tales fines.

*Pasos y recursos metodológicos en esta etapa:*

➤ *Primer paso:* desarrollo de la movilidad de los órganos articulatorios (lengua, labios, maxilar inferior, velo del paladar). Se utilizan recursos metodológicos como: las praxias articulatorias (abrir la boca, sacar la lengua y llevarla a izquierda y derecha; sacar la lengua larga y fina, corta y ancha; relamerse con la punta de la lengua los labios superior e inferior en movimiento circular de izquierda a derecha y viceversa, proyectar los labios unidos, llevarlos a derecha e izquierda).

➤ *Segundo paso:* desarrollo de la atención y discriminación auditiva. Se favorece con recursos metodológicos como: juegos de discriminación de ruidos y sonidos (los escolares se moverán al escuchar ruidos y sonidos y se inmovilizarán al cesar estos), localización de la dirección del sonido (con los ojos tapados, señalar de dónde procede el sonido), imitación de secuencias rítmicas sencillas (tata tatatá, tatatá-tatá), imitación de sonidos vocálicos y consonánticos que los escolares no tengan afectados, pronunciación de palabras encadenadas (pronunciar palabras que comiencen por la sílaba que termina la anterior: mesa-sapo-pote, repetición de dos o tres palabras respetando el orden de las sílabas que se propone: (juguete, juguetero, juguetón).

También se trabaja la asociación de lo descrito con lo observado (los escolares ordenan láminas o secuencias según la descripción que realice el maestro logopeda, otro escolar o él mismo). La segmentación oral de palabras, frases, oraciones apoyados con palmadas, representadas con signos gráficos, completar frases y oraciones añadiendo nuevas palabras con tarjetas ilustradas, el dictado de palabras, frases en tiras gráficas y su análisis favorecen el desarrollo de la memoria auditiva y el oído fonemático.

➤ *Tercer paso:* desarrollo del componente sonoro del lenguaje. En este paso se trabaja la respiración, las cualidades de la voz (tono, timbre, intensidad), la entonación, el ritmo y la fluidez verbal.

El trabajo con la respiración se beneficia con la utilización de recursos metodológicos como: la orientación de los momentos de la respiración para el habla; ejercicios

respiratorios: espiración emitiendo palabras, frases y textos sencillos, lectura realizando la inspiración nasal en las pausas. El maestro logopeda solicitará a los escolares que tomen el aire necesario para hablar.

Las cualidades de la voz comprende el tono, timbre, intensidad, para ello, se utilizan recursos metodológicos como: aumentar y disminuir el tono vocal al pronunciar vocales aisladas o combinaciones de ellas y de sílabas, desplazar la voz de tonos graves a medios y agudos, previa inspiración y viceversa.

El desarrollo del timbre se logra con la repetición de combinaciones silábicas de forma marcada y sonora, aumentar y disminuir la altura vocal al pronunciar sílabas con consonantes sonoras en una espiración o hacer pausas.

Para la intensidad se utiliza el alongamiento de sonidos y vocales, se pueden realizar en una sola espiración o hacer varias pausas inspiratorias, pronunciar sílabas o combinaciones de estas de golpe o al aumentar y disminuir la intensidad, conteo numérico aumentando y disminuyendo la intensidad vocal, realizar variaciones de intensidad cuando el contenido de la comunicación oral lo requiera. El maestro logopeda solicita y recuerda a los escolares que siempre deben hablar en voz baja, con una intensidad normal y explicar a los escolares la importancia del cuidado de la voz.

La entonación melódica de la voz se facilita con recursos metodológicos como la técnica de la inflexión y la entonación, la lectura expresiva, la primera consiste en repetir frases cortas y sencillas de manera que se marque con una onda suave la sílaba correspondiente a cada acento prosódico u ortográfico; la segunda enfatiza en

la distinción de las características acústicas del discurso. Facilitan la expresividad del discurso oral.

➤ *Cuarto paso:* desarrollo de la comprensión, el análisis y la construcción de textos orales.

En este paso, se desarrollan las dimensiones del discurso (semántica, sintáctica y pragmática) y las microhabilidades del habla y la escucha. También se trabajan las etapas de pronunciación: preparatoria, instauración, automatización y diferenciación de los sonidos afectados, según niveles de articulación, la afectación o no del oído fonemático y la forma en que se manifiesta el trastorno (omisión, distorsión, sustitución, adición, transposición).

Se utilizan recursos metodológicos como el espejo en la etapa de instauración; tarjetas ilustradas para la pronunciación de sonidos en sílabas, palabras, oraciones y en el lenguaje espontáneo. La imitación de posiciones articulatorias y la ayuda (mecánica, cenestésica), permiten la instauración de los sonidos afectados, esta última, también favorece la diferenciación de los sonidos. El trabajo con las etapas de la pronunciación de los sonidos de la lengua, debe tener lugar en varios momentos del tratamiento logopédico. La ayuda del maestro logopeda y de otros especialistas (psicólogo, psicopedagogo, en los casos necesarios, posibilitan la atención integral de los escolares en el tratamiento logopédico.

El análisis discursivo funcional y la creación de situaciones comunicativas, permiten a los escolares, a partir de sus vivencias, experiencias, construir discursos orales de forma sencilla, con coherencia, corrección, fluidez sobre temas que se correspondan

con sus edades y experiencias al posibilitarles el análisis reflexivo de determinadas estructuras que les permiten descubrir su funcionalidad, desarrollar estrategias para comprender y producir significados y poner a los escolares en situaciones de interacción en contextos reales o imaginados.

El sistema de preguntas, las láminas, secuencias y objetos reales, se utilizan como ayuda para facilitar la comunicación oral de los escolares. Las preguntas deben responder a los niveles de comprensión y construcción de textos orales (traducción, interpretación y extrapolación). El uso de estrategias de muestreo, inferencias y predicción facilitan las microhabilidades del habla y la escucha (la comprensión del contenido de un discurso, las ideas principales y secundarias, el significado global del mensaje, seleccionar palabras e informaciones relevantes, la intención y la finalidad comunicativa, cambiar el final de un cuento e inferir el título de un texto).

*¿Cómo desarrollar la comprensión, el análisis y la construcción de textos orales, en el tratamiento logopédico?*

Por ejemplo, se presenta una lámina que representa una fiesta por el día del maestro, se realizan las preguntas siguientes: ¿qué observan en la lámina?, ¿qué creen que está pasando?, ¿por qué estarán haciendo una fiesta?, ¿quiénes preparan la fiesta de la maestra?, ¿les gustan las fiestas?, ¿por qué?, ¿si la fiesta fuera de cumpleaños, cómo les gustaría hacerla?, ¿cómo son las fiestas?, se les pide que expresen una palabra que signifique lo mismo o lo contrario de la expresada, ¿qué palabras de las que hemos mencionado me dicen cómo son las fiestas? Esas

palabras son largas o cortas, ¿cómo te imaginas la fiesta de tu cumpleaños? Vamos a ponerle nombre a la lámina.

Si los escolares han adquirido el código de la lectura y la escritura, se pueden utilizar pequeños fragmentos de lectura, seleccionadas de los libros de textos de primer y segundo grados o elaboradas por el maestro logopeda y combinarse procedimientos orales y escritos como:

La lectura expresiva favorece la comprensión de los cambios de significados en las palabras, los escolares reconocen la intención comunicativa, si se afirma, interroga, exclama, por ejemplo. ¿Vamos a la playa?, ¡vamos a la playa!, vamos a la playa.

La escucha con respuestas cortas expone a los escolares a diálogos cortos u oraciones para los cuales tienen que proveer respuestas breves, inmediatas, generalmente no verbales como discriminar información falsa o verdadera. Ejemplo. El maestro logopeda formula varias frases y los escolares seleccionan la falsa y la expresan de forma correcta (todas las plantas tienen espinas, las flores de las plantas son perfumadas, los niños cuidan las plantas), dibujar sobre lo escuchado, ordenar fotos o dibujos a partir de un cuento, diálogo).

La escucha con respuestas más extensas conduce a los escolares a desarrollar un tema, a relacionarlo con uno tratado anteriormente, precisar y resumir las ideas importantes, reformular lo que se ha dicho, aplicar las reglas gramaticales de la lengua. En este sentido se realizan actividades como: completar espacios en blanco, anticipar una idea, repetir y resumir un texto sencillo, ya sea de forma oral o escrita.

El ordenamiento de secuencias y tarjetas de acciones con apoyo de consignas dadas. El maestro logopeda utiliza dibujos que los escolares deben ir colocándolos de izquierda a derecha en función de las consignas dadas. Ejemplo: el niño está saltando, antes de saltar ha jugado a la pelota, después de saltar mira la televisión, antes de mirar la televisión hace la tarea.

Las descripciones favorecen la comprensión y producción de discursos orales, los escolares deben observar y buscar detalles nunca antes percibidos, comenzar por lo más cercano a lo más lejano en el espacio o en el tiempo, si se trata de un rostro, desde arriba hacia abajo, donde se utilicen sustantivos y adjetivos variados para evitar repeticiones. En sus inicios el maestro logopeda puede facilitarles a los escolares un listado de adjetivos que ayuden la descripción.

La narración oral de cuentos, historietas, paseos, sucesos con una estructura favorece la comprensión del contenido de un discurso, el significado global del mensaje, así como seleccionar la información útil y necesaria. Es necesario enseñar a los escolares en la estructura de esta, al utilizar preguntas como: ¿quién o quiénes son los protagonistas? (personajes), ¿qué les ocurre? (acción o suceso), ¿dónde? (espacio), ¿cuándo? (tiempo), ¿quién se tomó la sopa?, ¿qué pasó después?

Los escolares pueden hacer dibujos o escribir textos sencillos acerca de las descripciones y las narraciones que realicen.

Para el desarrollo pragmático, se utilizan recursos metodológicos como el modelo comunicativo del maestro logopeda y de los escolares, que comprende hacer uso

adecuado del tono, e intensidad de la, voz, de la entonación, pronunciación, fluidez de la expresión, expresiones del rostro, gestos.

Enseñar a los escolares a percibir y expresar estados de ánimos, sentimientos, emociones, intercambiar opiniones acerca de un tema determinado donde se respeten las opiniones de los demás, se pida la palabra para hablar, se faciliten muestras de cortesía, se desarrollen actividades de expresión y creatividad en el discurso. Por ejemplo, con el uso de la voz y los gestos, por parejas, uno dice, yo te voy a regalar y hace el gesto correspondiente, mientras dice el nombre del regalo, después lo hará su compañero.

La variedad de recursos metodológicos son sugerencias a seleccionar por el maestro logopeda de acuerdo con los objetivos del sistema de tratamientos logopédicos.

### *Etapas 3. Conclusiones.*

En esta etapa el objetivo es valorar el grado de satisfacción que sienten los escolares en el tratamiento logopédico.

En este caso se realiza el análisis de los resultados individuales y colectivos a partir del cumplimiento del objetivo, se orienta la tarea, se precisan las acciones a concretar con la familia y el maestro del aula, según los resultados del tratamiento logopédico.

➤ *Primer paso:* valoración de la satisfacción de los escolares por la actividad.

En este paso se utiliza como recurso metodológico la conversación, el diálogo, se pregunta a los escolares si les gustó la actividad y por qué, para que emitan sus criterios.



El maestro logopeda propicia entre los escolares la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, de forma crítica en una relación de amistad, afectiva, participativa, en un ambiente de trabajo conjunto a partir de criterios, indicadores que les permitan conocer qué lograron y qué no lograron.

Una vez que los escolares se hayan evaluado, el maestro logopeda realiza la valoración final de la actividad y la evaluación individual de cada escolar. En este momento es importante que los escolares adquieran conciencia de lo que han logrado con respecto al objetivo propuesto en el tratamiento logopédico y en qué aspectos deben mejorar para obtener los resultados deseados.

Para la evaluación individual se utilizan categorías de muy bien, con aquellos escolares que cumplieron el objetivo, bien, aquellos que cumplieron el objetivo parcialmente y regular con los que no lo lograron. Por ejemplo, si en el tratamiento logopédico se trabaja la etapa preparatoria, donde se desarrollan las praxis articulatorias, que constituyen las bases funcionales para la pronunciación correcta del sonido /ř/, el objetivo del tratamiento logopédico será mover la lengua en diferentes direcciones, que es el órgano articulatorio encargado de la emisión de ese sonido.

La evaluación se realiza de forma integral con énfasis en el objetivo. En este caso se evalúan de muy bien los escolares que siempre lograron la movilidad lingual y realizaron las actividades con entusiasmo, de bien, aquellos que la lograron de forma inconstante y realizaron las actividades con entusiasmo y de regular, los que no la logran. El maestro logopeda invita a los escolares que han trabajado bien a continuar esforzándose para que logren mover la lengua siempre en todas las posiciones y los que lo han hecho

regular los estimula para que traten de lograrla. Se utilizan como recursos metodológicos la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.

➤ *Segundo paso:* orientación de la tarea. Se realiza en correspondencia con el cumplimiento del objetivo del tratamiento logopédico. Se utilizan recursos metodológicos como la explicación, la demostración, entre otros.

➤ *Tercer paso: orientación al maestro y a la familia.* La orientación se realiza de forma sistemática, en correspondencia con el desarrollo alcanzado por cada escolar en el tratamiento logopédico. En este paso se utilizan recursos metodológicos como las libretas de visitas a clases y orientaciones al maestro y la de labor social, las que orientan a estos agentes de socialización en las actividades a realizar con los escolares, además de la explicación y la observación de tratamientos logopédicos.

En la aplicación de la metodología propuesta se contemplaron tres etapas con sus correspondientes pasos, las que se tuvieron en cuenta en la valoración de los resultados.

La metodología tiene su salida en el tratamiento logopédico como parte de la atención logopédica en general, la que se organiza por etapas, por tanto está precedida de una exploración logopédica con su correspondiente diagnóstico en el mes de septiembre. Además, previa a su ejecución se realizaron los talleres metodológicos para la preparación de los maestros logopedas involucrados en la investigación, es decir mensualmente durante un curso escolar y como parte del sistema de trabajo metodológico de la escuela, con la participación de los maestros

de aulas y las familias. Se emplean los folletos de orientación para los agentes de socialización.

La segunda etapa se corresponde con la ejecución de la metodología, en el curso escolar 2012-13, en los meses de octubre a mayo. Su objetivo estuvo dirigido a aplicar los tratamientos logopédicos a partir del diagnóstico de la comunicación oral de los escolares. El primer paso fue la demostración de tratamientos logopédicos, a partir de la integración de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua, las dimensiones del discurso, los procesos del habla y la escucha, así como la aplicación de los recursos metodológicos.

La etapa de control de la propuesta tiene como objetivo valorar el cumplimiento por el maestro logopeda de los pasos y aplicación de los recursos metodológicos, ellos son:

- Primer paso: control de las etapas y pasos de la metodología.
- Segundo paso: valoración de los resultados al aplicar los recursos metodológicos en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral.

También es oportuno precisar algunas sugerencias metodológicas para su aplicación. Las primeras están relacionadas con la exploración logopédica, aunque no se incluye como una etapa de la metodología es muy importante considerarla por la relación que tiene el binomio diagnóstico e intervención logopédica. Las segundas, están dirigidas a los elementos didácticos del tratamiento logopédico en sus

diferentes etapas, reveladas como carencias en el diagnóstico, con el propósito de potenciar el desarrollo de la comunicación oral. A continuación se señalan:

- Al concluir la exploración logopédica con la recogida de información y la precisión del diagnóstico explicativo con la estrategia general de intervención logopédica, se procede a la planificación del sistema de tratamientos logopédicos.
- El análisis de los expedientes logopédicos para valorar los aspectos que se recogen en la hoja de exploración logopédica acerca de la comunicación oral de los escolares.
- Comprobación de la orientación a los agentes de socialización acerca del estado del desarrollo de la comunicación oral, es decir, el conocimiento del diagnóstico inicial por parte del maestro de aula y la familia.
- Se realiza el análisis de documentos como las libretas de visitas a clases y orientaciones al maestro y la de labor social, en estas últimas se obtiene información acerca de las orientaciones que brinda el maestro logopeda para el seguimiento al tratamiento logopédico, el que comienza desde el diagnóstico inicial.
- Demostración de exploraciones logopédicas con diferentes propósitos a explorar en el sistema de trabajo metodológico de la escuela. Se sugiere el estudio de caso.

Actividades que se sugieren en la etapa preparatoria que está relacionada con la preparación de las bases funcionales para el habla y la escucha:

¿Cómo proceder en diferentes tratamientos logopédicos?

*1. Objetivo. Colocar los órganos articulatorios en la posición adecuada, si el escolar tiene dificultades en lograr la posición articulatoria para pronunciar determinado sonido.*

*Ejemplo. Colocar la lengua en la posición articulatoria correcta.*

*Método. Conversación.*

*Procedimientos. Demostración de la posición articulatoria correcta de la lengua, observación de la posición articulatoria correcta de la lengua, explicación.*

*Medios. Espejo colectivo e individual*

*2. Objetivo. Mover los órganos articulatorios para la pronunciación del sonido, si el escolar tiene dificultades para la movilidad de los órganos articulatorios.*

*Ejemplo: mover la lengua en varias direcciones, mover el velo del paladar, mover los labios, según el órgano articulatorio.*

*Método. Observación*

*Procedimientos. Conversación, demostración, explicación.*

*Medios. Espejo colectivo e individual*

*Si el escolar se encuentra en la etapa de instauración:*

*3. Objetivo. Practicar la respiración para el habla*

*Método: Demostración*

*Procedimientos. Observación, imitación de patrones respiratorios*

*Medios. Bolitas de algodón, hojas de papel, una flor para oler, otros.*

*4. Objetivo. Pronunciar el sonido*

*Método: Conversación.*

*Procedimientos. Demostración de la pronunciación correcta del sonido, imitación de la pronunciación del sonido*

*Medios. Espejo colectivo e individual*

*En la etapa de automatización de los sonidos:*

*4. Objetivo. Pronunciar el sonido en (sílabas, palabras, oraciones, lenguaje espontáneo), según sea el caso.*

*Método. Descripción de láminas, narración de secuencias, cuentos, lectura de pequeños fragmentos, entre otros.*

*Procedimientos: Repetición del sonido en sílabas, palabras, oraciones y en el lenguaje espontáneo.*

*Medios. Láminas, tarjetas ilustradas, libro de texto, fragmentos de lecturas, entre otros.*

*En la etapa de diferenciación*

#### *5. Objetivo. Discriminar el sonido*

*Método: Descripción*

*Procedimientos. Diferenciación del sonido en sílabas, palabras, oraciones, según corresponda, segmentación de palabras, frases oraciones, otros.*

*Medios. Láminas, tarjetas, tiras de papel, entre otros*

#### *2.4. Valoración de los resultados alcanzados con la aplicación de la metodología.*

La enseñanza de los procesos de hablar, escuchar, leer y escribir constituye una prioridad de la escuela primaria cubana por la importancia que posee en la formación integral de la personalidad, el aprendizaje y la socialización de los escolares. Por ello, la búsqueda de una respuesta en el plano de la investigación pedagógica es objeto de estudio desde el curso escolar 2011-2012.

Para valorar los resultados alcanzados después de aplicada la metodología, se realiza la triangulación de fuentes: encuesta a los 5 maestros logopedas que aplicaron la propuesta (anexo 4), la entrevista final a maestros de aula (anexo 13) y a la familia (anexo 14) y la observación final a tratamientos logopédicos (anexo 16). En el anexo 15 se muestra la valoración final de la triangulación de fuentes.

En la valoración final de los resultados, en la dimensión cognitivo instrumental, el indicador referido al dominio del tratamiento logopédico, se constata mejor precisión del diagnóstico logopédico, por los maestros logopedas, al hacerse explicativo, lo que permite realizar el diagnóstico diferencial de las dislalias. Los maestros logopedas

mostraron dominio de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, así como de las dimensiones del discurso, pero deben profundizar en el dominio de los recursos metodológicos, lo que repercute en la orientación a los maestros de aula y la familia. En este caso la evaluación final se ubica en el rango de poco adecuado.

En el indicador dominio de los procesos del habla y la escucha, los maestros logopedas demostraron mayor conocimiento al señalar los elementos esenciales de cada uno, y reconocer la respiración, el ritmo, fluidez del lenguaje, calidad de la voz, la entonación como bases funcionales para desarrollar estos procesos.

En cuanto al dominio de los recursos metodológicos, se evidencia un mejor conocimiento de estos, se precisa la motivación para el tratamiento, el análisis discursivo funcional, el sistema de preguntas relacionadas con los niveles de comprensión de textos, estrategias de muestreo, inferencias, la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, entre otros.

*En la dimensión docente metodológica,* los tres indicadores evolucionaron favorablemente de un rango inadecuado a adecuado, a pesar de la complejidad en la planificación del sistema de tratamientos logopédicos, se evidencia la integración de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, se tienen en cuenta los métodos y procedimientos, realizan acciones para desarrollar los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, se trabajan sistemáticamente las dimensiones del discurso.



En la creación de condiciones hay mejor selección del material verbal y se realizan acciones para el desarrollo de la respiración, cualidades de la voz, ritmo y fluidez del lenguaje, elementos esenciales para el desarrollo de la comunicación oral.

En el tratamiento metodológico a los procesos del habla y la escucha, se aplican estrategias de comprensión de textos, fundamentalmente las de predicción, se debe continuar el trabajo para perfeccionar el uso de estas, en el empleo de los recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación oral, entre los más utilizados se encuentran las preguntas de apoyo que responden a los niveles de comprensión, el análisis discursivo funcional, la descripción de láminas, las narraciones de secuencias, lectura expresiva y la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación-

Los logros alcanzados por los maestros logopedas, se reflejan en los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los maestros de aula y la familia, los primeros, al preguntarles qué acciones realizan en sus clases para el desarrollo de la comunicación oral de los escolares con dislalia funcional plantean lectura en alta voz, expresiva, escucha con respuestas cortas y largas, ordenamiento de secuencias y tarjetas de acciones con apoyo de consignas dadas, entre otras.

Por otra parte las familias refieren que les exigen a los escolares hablar en voz baja, esperar su turno para hablar. Entre las actividades que realizan con sus hijos se encuentran completar el final de un cuento, mencionar el antónimo y sinónimo de palabras, realizar paseos y hacerles preguntas sobre este.

*En la dimensión orientación educativa, en el indicador modelo comunicativo del maestro logopeda, se considera la utilización de un lenguaje claro, fluido, con buena entonación,*

en correspondencia con la edad y el grado, orientarlos con precisión en la actividad, que su lenguaje debe ser modelo a imitar por los escolares, lo que se corresponde con lo observado en los tratamientos logopédicos. Este indicador se comportó desde el inicio en adecuado.

*El ambiente emocional* después de aplicada la metodología evolucionó de un rango de poco adecuado a adecuado, se debe destacar la concientización por parte de los escolares de los logros y dificultades para mejorar el desarrollo de la comunicación oral, en un clima de afecto y ayuda.

Finalmente, el último indicador, evolucionó de un rango inadecuado a adecuado. En él se destaca la orientación educativa a los maestros de aula y la familia, así como en las ayudas brindadas al escolar para mejorar los procesos del habla y la escucha en función del desarrollo de la comunicación oral.

Para la valoración de los resultados finales del pre-experimento una vez aplicada la metodología, se tuvo en cuenta el comportamiento de los indicadores de la observación a tratamientos logopédicos. A continuación se ilustra en la figura 3 la constatación final del comportamiento de la variable.

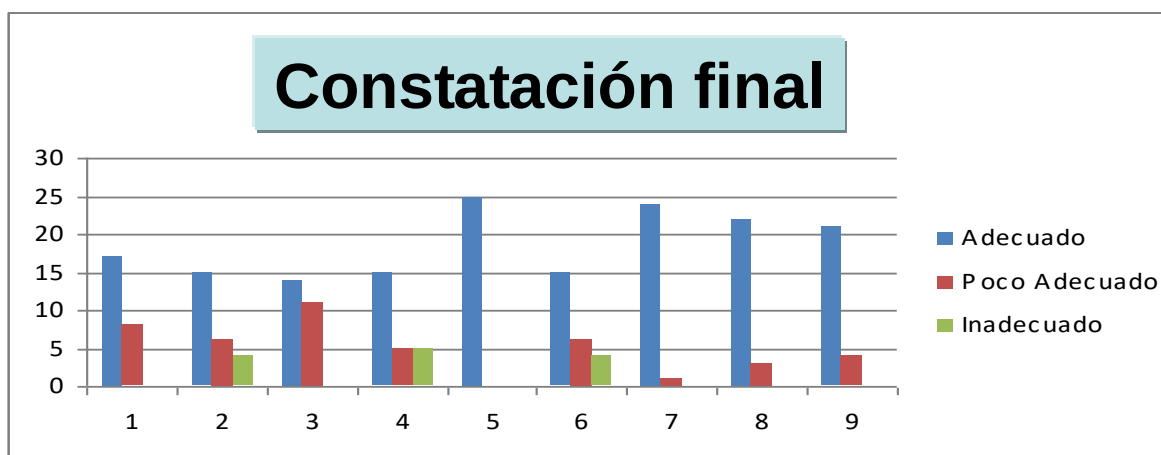


Fig.3. Resultados de la observación final a tratamientos logopédicos

En la *dimensión cognitivo instrumental*, en el indicador dominio del tratamiento logopédico, 17 (68%) de ellos fueron evaluados de adecuados y 8 (32%) de poco adecuado, según la tendencia central se ubican en un rango de adecuado. En ellos se integran los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, aunque hay que continuar profundizando en los métodos y procedimientos, en función del objetivo propuesto.

En el indicador dominio de los procesos del habla y la escucha, 15 (60%) de los tratamientos logopédicos fueron evaluados de adecuados, 6 (24%) poco adecuados y 4 (16%) inadecuados, el rango final alcanzado fue valorado de adecuado.

En los tratamientos logopédicos observados se realizan actividades para el desarrollo de las dimensiones del discurso como sistema lingüístico, los componentes funcionales de la lengua y el componente sonoro del lenguaje, se incluyen actividades para la respiración, voz, pronunciación, entonación, ritmo y fluidez del lenguaje, lo que facilita el desarrollo de las bases funcionales de la comunicación oral.

En el tercer indicador, dominio de los recursos metodológicos para el tratamiento logopédico se evalúan 14 (56%) de adecuados y 11 (44%) de poco adecuados, la tendencia central del rango se comporta en adecuado. Después de aplicada la metodología se observa la variedad de recursos metodológicos aplicados en los diferentes momentos de esta actividad pedagógica, en diferentes situaciones

comunicativas que revelan el cambio en cuanto al desarrollo de las dimensiones del discurso en la comprensión y construcción de textos orales, se utilizan en los diversos pasos de la metodología de acuerdo con el diagnóstico inicial de los escolares y el objetivo del tratamiento logopédico.

En la dimensión docente metodológica, en el indicador *planificación del sistema de tratamientos logopédicos*, 15 (60%) resultaron adecuados, 5 (20%) poco adecuados y 5(20%) inadecuados, la tendencia central se ubica en el rango de adecuado.

Este indicador que exige de la integración de los componentes de la didáctica general y en particular, la referida a la enseñanza de la lengua, a pesar de su complejidad hubo cambios después de aplicada la metodología, lo que da cuenta de su viabilidad en la práctica pedagógica, sin embargo, es necesario profundizar en la aplicación de los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua para propiciar el desarrollo del habla y la escucha como base de la comunicación oral.

En cuanto al dominio y orientación del objetivo de los tratamientos logopédicos, se precisa el objetivo de este y se revela de forma clara en el sistema de actividades. Se integran los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, aunque se debe continuar el trabajo con los métodos y procedimientos, se debe destacar la integración de las dimensiones del discurso, los componentes funcionales de la lengua y los procesos del habla y la escucha en los diferentes tratamientos logopédicos.

Estos resultados se deben a la preparación de los maestros logopedas en los talleres metodológicos y en el sistema de trabajo metodológico de la escuela para la aplicación de la metodología.

En el tratamiento metodológico a los componentes funcionales de la lengua se promueve el análisis de textos orales, que permiten la comprensión y construcción de textos orales, con una intención y finalidad comunicativa. En el trabajo con el componente sonoro del lenguaje se incluyen actividades dirigidas a este fin.

En los tratamientos logopédicos se motiva a los escolares para esta actividad, la revisión de la tarea se hizo más sistemática, lo que propició mayor preocupación de los escolares por la actividad. Este constituye un aspecto esencial durante todo el tratamiento, por tanto no puede ser improvisado, debe estar previsto en la planificación a partir del diagnóstico de los escolares.

En cuanto a los recursos metodológicos utilizados, se hace más variado su uso, lo que influyó en la motivación para la actividad. Referente al modelo comunicativo del maestro logopeda estos fueron precisos en sus ideas al comunicar el objetivo, con un vocabulario asequible a las condiciones del desarrollo de los escolares, que facilitó la orientación de la actividad.

El indicador creación de condiciones para el tratamiento logopédico se comportó muy favorable porque 25 (100%) tratamientos logopédicos fueron valorados de adecuado. En la observación se constata que el maestro logopeda tiene en cuenta el material verbal en correspondencia con la etapa de trabajo con la pronunciación y el eje temático que se desarrolla. Se evidencia el trabajo con el componente sonoro del

lenguaje, con énfasis en el ritmo, la respiración, la voz, la entonación, así como la consideración de las expresiones corporales como complementos de la comunicación oral.

En el indicador tratamiento metodológico a los procesos del habla y la escucha, 15 (60%) tratamientos logopédicos fueron evaluados de adecuados, 6 (24%) poco adecuados y 4 (16%) de inadecuados. El análisis de la tendencia central ubica este indicador en el rango de adecuado.

En los procesos del habla y la escucha se evidenció la aplicación de estrategias de comprensión y construcción de textos orales en diferentes situaciones comunicativas, se incluyeron actividades de seleccionar palabras e ideas relevantes de un discurso, completar oraciones, inferir el título de un cuento o lectura, el final del cuento, entre otros.

En la dimensión orientación educativa, el indicador modelo comunicativo del maestro logopeda, en los 25 (100%) tratamientos logopédicos desde el inicio de la investigación fue evaluado de adecuado en el grupo de estudio porque estos fueron precisos en sus ideas al comunicar el objetivo, con un vocabulario asequible a la edad que facilitó la orientación de la actividad.

En el indicador, ambiente emocional, 22 (88%) tratamientos logopédicos fueron evaluados de adecuados y 3 (12%) de poco adecuados, en general en este caso el rango se ubica en adecuado.

En este indicador se motivó a los escolares durante todo el tratamiento logopédico y sus dificultades fueron señaladas en un clima de afecto, de cariño, de solidaridad y

ayuda. También se constató que los maestros logopedas conciben la evaluación durante toda la actividad, propician la concientización de las habilidades alcanzadas por los escolares y combinan distintas formas de evaluación que permiten la participación activa de los escolares.

El último indicador valorado fue las relaciones de ayuda que establece con los escolares y agentes de socialización, el que se comportó en 21 (84%) tratamiento logopédico adecuado y 4 (16%) poco adecuado, el que al analizar la tendencia central se expresa en un rango adecuado. En él se ofrecen diferentes tipos de ayudas, las que favorecen un mejor desarrollo de la lengua materna.

La orientación de la tarea, se observó la correspondencia con el objetivo y la disposición del maestro logopeda por propiciar la creación de situaciones sociales del desarrollo de los escolares en diferentes situaciones comunicativas.

En la orientación a los agentes de socialización se debe destacar la participación de la familia en los tratamientos logopédicos de sus hijos y la repercusión positiva que tuvo en la continuidad del tratamiento logopédico.

En resumen, el análisis de la observación de los tratamientos logopédicos después de aplicada la metodología se realizan las consideraciones siguientes:

- Se constata una mejor preparación teórico-metodológica de los maestros logopedas al concebir el sistema de tratamientos logopédicos.
- Se emplean en el 100% de los tratamientos logopédicos los recursos metodológicos para el desarrollo de los procesos del habla y la escucha.

- En los tratamientos logopédicos observados se revela la integración de las dimensiones del discurso en diferentes situaciones comunicativas y su relación con el desarrollo de los procesos del habla y la escucha.
- Se debe destacar la relación con los agentes de socialización (familia- maestro de aula), quienes desempeñan una labor educativa importante en la continuidad del tratamiento logopédico.
- El tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional requiere de mayor sistematización de los componentes funcionales del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua.



### *Conclusiones del capítulo*

En el capítulo II se aplicó la operacionalización de la variable objeto de investigación con sus dimensiones e indicadores, a partir de esta se procedió al análisis del proceso y los resultados del diagnóstico inicial, en el que se constatan las carencias teóricas y metodológicas del maestro logopeda para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, las que tienen su influencia en el resto de los agentes de socialización.

El referido proceso permite buscar una vía de solución al problema que se investiga, la que se concreta en una metodología basada en el enfoque histórico cultural, la didáctica de la lengua y la orientación educativa, desde una dimensión preventiva del proceso educativo para favorecer el desarrollo de la comunicación oral en este contexto. Se trata de una herramienta didáctica para mejorar la calidad del tratamiento logopédico. Su aplicación mediante una triangulación de fuentes y un pre-experimento corrobora su viabilidad y validez científica.

## Conclusiones

- El análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral del escolar primario con dislalia funcional, reveló la necesidad de profundizar en su concepción didáctico-metodológica, desde los sustentos del enfoque histórico cultural, la integración de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, y en particular de la didáctica de la lengua, con la orientación a los agentes de socialización, a partir de una visión preventiva del proceso educativo.
- La sistematización del estudio realizado evidenció que el desarrollo de la comunicación oral tiene como base los procesos del habla y la escucha, los que permiten la comprensión y construcción de significados que deben ser considerados en el tratamiento logopédico y mediados por recursos metodológicos.
- El diagnóstico del problema que se investiga reveló las carencias teóricas y metodológicas del maestro logopeda en el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral, su desactualización en la temática y la necesidad de cambiar la práctica pedagógica en la Educación Primaria, a partir de una mejor atención y prevención a los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

- La metodología que se propone se fundamenta en la concepción histórico cultural, la didáctica de la lengua, en particular, en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, así como en la orientación educativa, con el propósito de mejorar el tratamiento logopédico para el desarrollo de la comunicación oral en el escolar primario. Se estructura en etapas y pasos que favorecen los procesos del habla y la escucha, mediados por recursos metodológicos.
- La valoración de la metodología aplicada para el tratamiento logopédico al desarrollo de la comunicación oral, en el escolar primario con dislalia funcional, fue de adecuada en todas las dimensiones, lo que revela su viabilidad según el pre-experimento y la triangulación metodológica de fuentes.

## **Recomendaciones**

- Continuar profundizando en la metodología propuesta para favorecer la concepción metodológica del tratamiento logopédico y los procesos del habla y la escucha como base de la comunicación oral.
- Introducir los resultados de la metodología en otras poblaciones de maestros logopedas para su perfeccionamiento a partir de los resultados.
- Presentar los resultados la metodología propuesta en la comisión científica y de carrera del Departamento de Educación Especial, para su perfeccionamiento e introducción en el diseño curricular de la formación del maestro en la carrera de Logopedia.
- Divulgar los resultados obtenidos en este estudio por diferentes vías e intercambios con profesionales de la carrera de Logopedia, en aras de su perfeccionamiento.